

SKRIPSI

**PENGARUH INHALASI AROMATERAPI LAVENDER
TERHADAP PERUBAHAN NYERI PASIEN
POST SECTIO CAESAREA (SC)
DI RS PRIMA HUSADA
MALANG**



OLEH:

LITA OKTAVIAN

NIM: 2022035122

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
2024**

SKRIPSI

**PENGARUH INHALASI AROMATERAPI LAVENDER
TERHADAP PERUBAHAN NYERI PASIEN
POST SECTIO CAESAREA (SC)
DI RS PRIMA HUSADA
MALANG**

Proposal Skripsi ini Dilaksanakan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan
(S.Kep) dalam Program Studi S1 Keperawatan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang

Oleh:
LITA OKTAVIAN
NIM: 2022035122

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
2024

SURAT PERNYATAAN

Saya bersumpah bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah dikumpulkan orang lain untuk memperoleh gelar dari berbagai jenjang di Perguruan Tinggi manapun. Saya siap menyerahkan softcopy untuk keperluan institusi baik kepengarangan atau publikasi.

Jombang, 2024

Lita Oktavian

NIM: 2022035122

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah dikonsulkan dan siap dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan dalam sidang proposal pada:

Hari :

Tanggal :/...../2024

Oleh:

Pembimbing I

Kusuma Wijaya Ridi, S.Kep., Ns., MNS

NPP: 011305147

Pembimbing II

Gevi Mellya Sari Mariska, S.Kep., Ns., M.Kep

NIP: 011305119

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan ditetapkan
pada tanggal:

Ketua : Elly Rustanti, M.Sc (.....)
NPP: 011305107 Tanda tangan

Anggota I : Kusuma Wijaya Ridi, S.Kep., Ns., MNS (.....)
NPP: 011305147 Tanda tangan

Anggota II : Gevi Mellya Sari Mariska, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)
NIP: NIP: 011305119 Tanda tangan

Mengetahui,

Ketua STIKES Husada Jombang

Ka. Prodi Keperawatan STIKES
Husada Jombang

Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., MM
NPP: 010201001

Zuhrotul Umaroh, S.Kep., Ns
NPP: 011005072

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah dan kelimpahan rizki-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada Program Studi S1 Keperawatan STIKES Husada Jombang.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., MM., selaku Ketua STIKES Husada Jombang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di lingkungan kampus yang dipimpinnya;
2. Zuhrotul Umaroh, S.Kep., Ns., selaku Ketua Program Studi Keperawatan STIKES Husada Jombang yang selama ini telah memimpin Program Studi Keperawatan dengan baik, sehingga proses transfer keilmuan bisa berjalan dengan baik pula;
3. Elly Rustanti, M.Sc., selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan naskah skripsi ini, sehingga menjadi lebih baik;
4. Kusuma Wijaya Ridi, S.Kep., Ns., MNS., selaku pembimbing I skripsi yang telah teliti memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi, sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan lancar;
5. Gevi Melly Sari Mariska, S.Kep., Ns., M.Kep., selaku pembimbing II skripsi yang telah membimbing penulisan skripsi ini dengan baik, sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan lancar;
6. Seluruh dosen Program Studi S1 Keperawatan STIKES Husada Jombang yang selama ini telah sabar mendidik peneliti selama proses pendidikan berlangsung;
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selama ini memberikan dukungan, baik moril maupun materil, sehingga peneliti bisa belajar dengan lancar; dan

8. Teman-teman yang selalu mendoakan, memberikan semangat, sehingga skripsi ini rampung tepat waktu.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Koreksi dan kritik sangat peneliti perlukan untuk menyempurnakan penulisan. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Jombang, 21 Februari 2024

Peneliti,

Lita Oktavian

NIM: 2022035122

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 <i>Sectio Caesarea</i>	9
2.2 Nyeri	14
2.3 Aromaterapi	19
2.4 Mekanisme Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri <i>Post SC</i>	23
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS.....	27
3.1 Kerangka Konsep	27
3.2 Hipotesis	28
BAB IV METODE PENELITIAN	30
4.1 Desain Penelitian	30
4.2 Kerangka Kerja.....	30
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	32
4.4 Variabel	33

4.5 Definisi Operasional	34
4.6 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
4.7 Pengumpulan Data.....	36
4.8 Pengolahan Data	38
4.9 Analisa Data	40
4.10 Etika Penelitian.....	41
4.11 Keterbatasan Penelitian	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	44
5.1 Hasil Penelitian.....	44
5.2 Pembahasan	48
5.3 Implikasi Keperawatan	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
6.1 Kesimpulan.....	57
6.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	28
Gambar	4.1 Model Penelitian dengan <i>Pre-Experiment Pretest – Posttest One Group Design</i>	31
Gambar	4.2 Kerangka Kerja Penelitian.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1 Definisi Operasional Penelitian.....	34
Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	44
Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat.....	45
Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	45
Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	45
Tabel 5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Bersalin.....	46
Tabel 5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Kehamilan...	46
Tabel 5.7 Hasil Identifikasi Skala Nyeri Pasien <i>Post SC</i> di RS Prima Husada Malang sebelum Diberikan Inhalasi Aromaterapi Lavender.....	46
Tabel 5.7 Hasil Identifikasi Skala Nyeri Pasien <i>Post SC</i> di RS Prima Husada Malang setelah Diberikan Inhalasi Aromaterapi Lavender	47
Tabel 5.8 Hasil Analisis Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Skala Nyeri Pasien <i>Post SC</i> di RS Prima Husada Malang.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1 Surat Permohonan Menjadi Responden Penelitian.....	66
Lampiran	2 Lembar Penjelasan Kepada Responden.....	67
Lampiran	3 <i>Informed Consent</i>	68
Lampiran	4 Lembar Observasi.....	69
Lampiran	5 SOP Pemberian Inhalasi Aromaterapi Lavender.....	71
Lampiran	6. Lembar Konsultasi.....	72
Lampiran	7 Tabulasi Data.....	74
Lampiran	8 Hasil Analisis SPSS.....	77

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
ACOG	: <i>American College of Obstetricians and Gynecologist</i>
CPS	: <i>Cycles Per Second</i>
Dinkes	: Dinas Kesehatan
FLACC	: <i>Face, Leg, Activity, Cry, Consolability</i>
GABA	: <i>Gamma Amino Butyric Acid</i>
KARU	: Kepala Ruangan
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
NRS	: <i>Numerical Rating Scale</i>
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SC	: <i>Sectio Caesarea</i>
TAMHD	: <i>The American Heritage Dictionary</i>
TTV	: Tanda Tanda Vital
VDS	: <i>Verbal Descriptor Scale</i>
VAS	: <i>Visual Analog Scale</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sectio Caesarea (selanjutnya disingkat SC) atau operasi sesar merupakan prosedur obstetri yang paling umum dilakukan di seluruh dunia. Persalinan dengan SC ini banyak menjadi pilihan karena alasan medis yang umumnya menyatakan bahwa persalinan secara normal tidak bisa dilakukan wanita hamil karena dianggap bisa beresiko pada ibu atau bayi yang dikandungnya (WHO, 2021). Hanya saja, persalinan SC ini bukan tanpa resiko. Laporan *American College of Obstetricians and Gynecologist* (ACOG) dalam Gedefaw *et al.* (2020) menyatakan bahwa persalinan SC secara signifikan meningkatkan kerentanan resiko terhadap morbiditas dan mortalitas. Komplikasi lain pasca SC adalah timbulnya nyeri akut pasca operasi tersebut dengan intensitas yang beragam (dari ringan hingga berat) dimana hal itu bisa mempengaruhi pemulihan pasca operasi, kepuasan pasien, keberhasilan menyusui dan ikatan ibu-anak (Roofthoof *et al.*, 2020). Jika pasien *post-SC* mengalami nyeri, maka biasanya hanya terjadi dalam 12 - 36 jam saja (Kasdu, 2020). Nyeri *post-SC* merupakan masalah utama yang sering diantisipasi pada periode pasca operasi tersebut. Karena pasien yang telah melakukan SC biasanya mengalami nyeri dengan intensitas beragam dari ringan hingga berat (Demelash *et al.*, 2021).

SC merupakan persalinan janin melalui sayatan terbuka pada perut (laparotomi) dan sayatan para rahim (histerotomi) (Sung and Mahdy, 2022).

World Health Organization (WHO, 2021) menyebut secara global 1 dari 5 (21%) wanita hamil melakukan persalinan dengan SC dan hal itu akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, bahkan pada tahun 2030 mendatang diperkirakan akan mencapai 29%. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) paling mutakhir dari Kementerian Kesehatan melaporkan prevalensi persalinan dengan SC di Indonesia mencapai 17,6% dan selebihnya persalinan normal (Kemenkes RI, 2018). Hanya saja, meskipun persentasenya masih berada di bawah persalinan normal, persentase SC tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar pada 1,3% - 6,8%. Salah satu provinsi yang melaporkan angka persalinan SC ini secara cukup signifikan adalah Jawa Timur. Data dari Dinkes Jatim (2020) sebagaimana dikutip Wathina *et al.* (2023) menyatakan persentase persalinan SC di Jawa Timur sebesar 22,36%. Selanjutnya, Data persalinan SC pada tahun 2022 (Januari-Desember) di Kota Malang mencapai 230 orang (Pemkot Malang, 2023). Kemudian jumlah pasien SC di ruang maternitas RS Prima Husada Malang pada 3 Oktober 2023 menunjukkan bahwa rata-rata 31 orang setiap bulannya.

Studi pendahuluan lanjutan yang peneliti lakukan pada 26 Oktober – 9 November 2023 terhadap 10 pasien *post-SC* di ruang maternitas RS Prima Husada Malang menunjukkan hasil sebanyak 70% pasien *post-SC* merasakan nyeri pada skala sedang dan 30% lainnya pada skala ringan berdasarkan pengukuran *Numeric Rating Scale* (NRS). Kepala Ruangan (Karu) ruang maternitas menyatakan bahwa rata-rata pasien yang telah melakukan operasi SC mengalami nyeri dengan intensitas yang berbeda mulai dari ringan hingga sedang. Biasanya, pasien *post SC* yang mengeluh nyeri diberikan terapi

farmakologis berupa obat-obatan dan umumnya nyeri yang dirasakan pasien mulai mereda di hari berikutnya.

Nyeri akut *post-SC* biasanya terjadi di bagian tubuh yang telah dibedah atau dioperasi yang berarti proses pembedahan yang mengakibatkan luka telah menyebabkan terjadinya nyeri (Demelash *et al.*, 2021). Selain karena faktor pembedahan, nyeri akut *post-SC* tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor penggunaan obat analgesik oral. Faktor lainnya adalah kecemasan sebelum tindakan operasi SC dan aktivitas merokok (Borges *et al.*, 2020). Oleh karena itu, nyeri akut *post SC* harus segera diatasi secara cepat dan tepat. Karena jika tidak, akan berdampak pada terbatasnya mobilisasi fisik ibu dan timbulnya beberapa komplikasi bagi pasien seperti halnya meningkatnya morbiditas, menurunnya kualitas dan fungsi hidup dan meningkatnya keterlambatan durasi atau waktu pemulihan (Purwaningtyas and Masruroh, 2020).

Nyeri akut *post SC* bisa diintervensi secara farmakologis dan non-farmakologis. Salah satu intervensi non-farmakologis (non-klinis) yang bisa digunakan untuk menangani nyeri *post SC* adalah aromaterapi (*aroma therapy*). Aromaterapi akan memberikan efek yang kuat pada emosi seseorang yang sedang diterapi. Ketika aromaterapi diberikan kepada seseorang, maka aromanya akan ditangkap oleh hidung. Selanjutnya, hidung akan menyampaikan informasinya secara lebih jauh kepada otak. Karena otaklah yang mengontrol emosi dan memori dan selanjutnya akan melanjutkan informasi yang ditangkap kepada hipotalamos yang pada dasarnya merupakan pengatur sistem di internal tubuh, suhu tubuh, sistem seksualitas dan reaksi atas stres yang terjadi. Efek lain yang ditimbulkan oleh aromaterapi adalah relaksasi

dan dapat mengurangi rasa nyeri serta mengurangi kecemasan. Oleh karena itu, ketika seseorang diberikan aromaterapi, maka efeknya akan merasa jauh lebih baik dari sebelumnya (dalam arti nyeri dan kecemasannya berkurang) (Tirtawati *et al.*, 2020).

Lavender merupakan salah satu jenis dari aromaterapi dalam bentuk *essential oil*. Aroma yang harum dan segar yang ditimbulkan oleh aromaterapi lavender memunculkan rangsang sensori ke reseptor sehingga sel neurokimia otak bekerja menstimulasi pengeluaran enkafelin yang berfungsi sebagai penghasil rasa tenang dan penghilang nyeri alami dari thalamus untuk mempengaruhi organ tubuh lainnya. Aroma lavender menghasilkan efek afrodisiak yang dihasilkan oleh rangsangan dari kerja endorfin kelenjar hipofis. Kelenjar hipofis selanjutnya melepaskan agen kimia ke sirkulasi darah untuk mengatur fungsi kelenjar lain seperti adrenal dan tiroid. Efek aromaterapi selanjutnya yaitu meningkatkan memori, meringankan stress, antidepresan, menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan energi (Rubianti *et al.*, 2022).

Cara kerja dari minyak esensial yang digunakan untuk aromaterapi, termasuk Lavender, yaitu pada saat molekul-molekul minyak esensial diterima oleh sel-sel reseptor di lapisan hidung karena dihirup, mengakibatkan terkirimnya sinyal-sinyal ke otak. Elektrokimia yang diterima oleh pusat penciuman kemudian berperan merangsang pelepasan kimia-kimia saraf dengan kuat ke dalam darah di otak untuk kemudian ditransportasikan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, di dalam paru-paru, molekul-molekul yang dihirup kemudian memasuki aliran darah dan masuk ke peredaran darah menuju ke seluruh tubuh. Minyak esensial yang dioleskan akan menembus folikel-folikel

rambut dan pori-pori kulit ketika digosokkan dan dipijat pada kulit kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah kapiler kemudian tersebar ke seluruh tubuh (Rubianti *et al.*, 2022). Kondisi inilah yang mengakibatkan berkurangnya skala nyeri pada ibu *post-SC*.

Penelitian ini perlu menggunakan terapi inhalasi aromaterapi Lavender sebagai bentuk terapi non-farmakologis untuk menurunkan nyeri pada pasien *post-SC*, karena kecenderungan teoritisnya menunjukkan manfaat yang berarti dalam menurunkan nyeri pasien. Aromaterapi ini sudah banyak digunakan oleh beberapa penelitian sebelumnya dalam kaitannya dengan efektifitasnya terhadap penurunan berbagai macam nyeri, salah satunya nyeri *post-SC*. Hanya saja, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ibu *post-SC* sesarea belum banyak yang mempergunakan metode ini dalam menangani nyeri yang muncul. Selain itu, sejumlah penelitian yang beberapa waktu terakhir dilakukan menunjukkan adanya kecenderungan hasil yang tidak seragam atau berbeda sama sekali antara satu penelitian dan penelitian lainnya. Penelitian Herawati *et al.* (2023) menyatakan aromaterapi Lavender berpengaruh signifikan terhadap nyeri *post-SC* ($P\text{-value} = 0,000$). Namun demikian, penelitian lainnya justru menunjukkan temuan berbeda. Salah satu penelitian yang dimaksud dilakukan Wijayanti *et al.* (2022). Hasilnya menunjukkan bahwa aromaterapi Lavender tidak berpengaruh signifikan pada nyeri persalinan dengan $P\text{-value} = 0,157 > 0,05$. Kecenderungan inilah yang menjadikan penelitian serupa penting dilakukan kembali dengan prosedur pelaksanaan aromaterapi Lavender yang lebih kokoh.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender

terhadap Perubahan Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh inhalasi aromaterapi Lavender terhadap perubahan nyeri pasien *post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inhalasi aromaterapi Lavender terhadap perubahan nyeri pasien *post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu;

- a. Mengidentifikasi skala nyeri pasien *post SC* di RS Prima Husada Malang sebelum diberikan inhalasi aromaterapi Lavender;
- b. Mengidentifikasi skala nyeri pasien *post SC* di RS Prima Husada Malang setelah diberikan inhalasi aromaterapi Lavender; dan
- c. Menganalisis pengaruh inhalasi aromaterapi Lavender terhadap perubahan nyeri pasien *post SC* di RS Prima Husada Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bisa secara teoritis dan bisa secara praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan tentang pengaruh inhalasi aromaterapi Lavender terhadap perubahan nyeri pasien *post Sectio Caesarea* (SC). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya terhadap masalah yang relevan.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

a. Bagi RS Prima Husada Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi kepada pemangku kebijakan di RS Prima Husada Malang tentang pengaruh inhalasi aromaterapi Lavender terhadap perubahan nyeri pasien *post SC*, sehingga bisa dijadikan terapi non-klinis tambahan dari terapi farmakologis yang diberikan kepada pasien *post SC*.

b. Bagi STIKES Husada Jombang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi/literatur untuk meningkatkan pengetahuan dan *evidence based* mahasiswa keperawatan serta bahan kepustakaan di STIKes Husada Jombang tentang pengaruh inhalasi aromaterapi Lavender terhadap perubahan nyeri pasien *post SC*.

c. Bagi Responden

Terapi yang secara statistik dinyatakan lebih berpengaruh signifikan untuk menurunkan nyeri *post* SC di dalam penelitian ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai terapi non-klinis untuk mengurangi nyeri yang diderita.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti sendiri dan peneliti lain yang hendak meneliti tema serupa untuk mengembangkan penelitian, sehingga temuannya menjadi lebih komprehensif.

e. Bagi Ilmu Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan literatur dalam bidang kajian keperawatan mandiri atau komplementer untuk mengatasi nyeri pada pasien *post*-SC. Hal ini karena kajian ini didasarkan pada penelitian yang berbasis pada eksperimen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Sectio Caesarea*

2.1.1 Definisi

Sectio cesarea (SC) merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan pada abdomen/laparoptomi dan uterus/histerotomi (ACOG, 2023). Pendapat senada juga menyatakan bahwa SC merupakan prosedur persalinan melalui pembedahan di bagian perut ibu dan rahim dalam rangka untuk mengeluarkan bayi (Akmal *et al.*, 2021). Sung and Mahdy (2022) menyatakan bahwa SC merupakan persalinan janin melalui sayatan terbuka pada perut (laparoptomi) dan sayatan para rahim (histerotomi). Berdasarkan tiga definisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa SC pada dasarnya merupakan alternatif persalinan untuk mengeluarkan bayi dengan menyayat atau membedah dinding perut dan rahim ibu. Sementara *post-SC* merujuk pada kondisi ibu yang telah melakukan persalinan dengan SC.

2.1.2 Indikasi SC

Persalinan dengan SC dilakukan dengan tiga indikasi, yaitu: mutlak, relatif dan sosial (Maryunani, 2020). Ketiga indikasi tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikasi mutlak

Indikasi mutlak ini bisa dari ibu dan bisa juga dari janin. Sejumlah indikasi yang berasal dari ibu antara lain: panggul sempit absolut; kegagalan melahirkan secara normal yang disebabkan tidak adekuatnya stimulus; terdapat tumor pada jalan lahir yang menyebabkan terjadinya obstruksi; stenosis serviks atau vagina; plasenta previa; distribusi frekuensi sefalopervik dan rupture uteri yang membakar. Sementara sejumlah indikasi yang berasal dari janin antara lain: malpresentasi janin; gawat janin; prolapse plasenta; perkembangan bayi yang terhambat; dan mencegah hipoksia janin (misalnya disebabkan oleh pre-eklamsia) (Maryunani, 2020).

2. Indikasi relatif

Indikasi yang sifatnya relatif ini misalnya karena ibu hamil sebelumnya sudah memiliki riwayat SC; presentasi bokong; distosia; gawat janin/fetal distress; pre-eklamsia berat, penyakit kardiovaskuler dan diabetes; ibu dengan HIV positif sebelum inpartu; hamil ganda dan herpes (Maryunani, 2020).

3. Indikasi sosial

Indikasi yang sifatnya sosial ini biasanya dilakukan ketika ibu hamil takut melahirkan karena pengalaman sebelumnya; ibu hamil yang ingin SC elektif untuk mengurangi resiko kerusakan panggul; dan ibu hamil yang takut terjadinya perubahan pada tubuhnya (*sexuality image*) setelah melahirkan (Maryunani, 2020).

Pendapat lain menyatakan bahwa indikasi dilakukannya SC ada dua, yaitu:

1. Indikasi berasal dari ibu

Persalinan secara *sectio-caesarea* dilakukan ketika dalam kondisi ibu dengan primigravida dengan kelainan letak, disproporsi sefalo pelvic (disproporsi janin atau panggul), ada primi paratua disertai kelainan letak, ada sejarah kehamilan dan kehamilan yang buruk, plasenta previa terutama pada primigravida, kesempitan panggul, solusio plasenta tingkat I-II, komplikasi kehamilan, kehamilan yang disertai penyakit dan karena atas permintaan.

2. Indikasi berasal dari janin

Persalinan secara *sectio-caesarea* dilakukan ketika janin memiliki indikasi kegagalan vakum atau forceps, ada distress janin atau gawat janin, malposisi kedudukan pada janin, malpresentasi dan polapsus tali pusat dengan pembukaan kecil (Solehati *et al.*, 2020).

2.1.3 Jenis-Jenis SC

Menurut Akmal *et al.* (2021), setidaknya ada lima jenis operasi SC, yaitu:

1. SC yang dilakukan dengan sayatan vertikal (klasik), sehingga hal itu memungkinkan adanya ruang yang lebih besar untuk mengeluarkan bayi. Hanya saja, SC jenis klasik ini saat ini sudah jarang dilakukan, karena sangat beresiko akan terjadinya komplikasi.

2. SC dengan sayatan mendatar yang dilakukan di bagian atas kandung kemih dan saat ini jenis sayatan ini paling umum dilakukan, karena cara tersebut bisa meminimalkan resiko pendarahan dan penyembuhannya berlangsung dengan cepat.
3. Histerotomi SC, yaitu operasi sesar yang diikuti dengan pengangkatan rahim dimana hal itu dilakukan dalam kasus ketika terjadi pendarahan yang sulit tertangani atau saat plasenta tidak bisa dipisahkan dari rahim.
4. Jenis lain dari SC seperti halnya SC ekstrapéritoneal (untuk meminimalkan terjadinya trauma pada bayi) atau SC porro (SC yang diikuti dengan pengangkatan rahim, saluran telur, dan indung telur).
5. SC berulang, yaitu tindakan bedah SC yang dilakukan saat pasien sebelumnya sudah pernah melakukan persalinan dengan SC.

2.1.4 Kontraindikasi

Tindakan SC biasanya tidak dilakukan pada beberapa situasi dan kondisi berikut ini: saat janin mati; ibu mengalami syok dan anemia berat; kelainan kongenital berat; infeksi ploidogenik pada dinding abdomen; dan minimnya fasilitas untuk melakukan persalinan dengan SC (Maryunani, 2020). Sung & Mahdy (2022) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada kontraindikasi yang sebenarnya untuk SC. Hanya saja, ada beberapa skenario klinis dimana SC bukan pilihan yang tepat. Kontraindikasi tersebut pada dasarnya bersifat relatif, seperti halnya ibu hamil yang mungkin menderita koagulopati parah, sehingga permedikasi menjadi

sangat berbahaya. Karena itu persalinan pervaginam mungkin menjadi lebih baik dibandingkan dengan SC.

2.1.5 Tanda dan Gejala

Saat ibu hamil melakukan SC, maka tanda dan gejalanya, yaitu: nyeri yang diakibatkan luka sayatan, terdapat luka insisi pada abdomen; terjadi kontraksi kuat di fundus uterus dan ulumbilicus; terdapat aliran lokea sedang dan bebas bekuan secara berlebihan; kehilangan darah $\pm$ 600-800ml selama pembedahan; emosi tidak stabil; terpasangnya kateter urinarius; tidak terdengarnya auskultasi bising usus; mual dan muntah (efek dari anastesi); status pulmonary bunyi paru jelas dan vesekuler; SC yang tidak direncanakan biasanya memicu kekurangpahaman prosedur; dan bayi yang lahir akan dibonding (Doenges, 2020).

2.1.6 Komplikasi *Post SC*

Ibu hamil yang telah melaukan SC seringkali mengalami sejumlah komplikasi, antara lain:

1. Pendarahan sebagai akibat dari tindakan sayatan atau pembedahan;
2. Infeksi puerperal, yaitu suatu infeksi bakteri dimana hal itu menyerang pada bagian tubuh reproduksi *post partum*;
3. Seringkali pada kehamilan selanjutnya, ibu hamil yang telah melaukan SC akan mengalami kurang kuatnya perut pada dinding uterus, sehingga hal itu akan menyebabkan rupture uteri.

4. Sejumlah komplikasi lain seperti halnya luka kandung kencing, embolisme paru-paru, dan sejenisnya (Doenges, 2020).

Penelitian Larsson *et al.* (2021) menunjukkan bahwa persalinan dengan SC telah meningkatkan resiko komplikasi seperti obstruksi usus, pembedahan untuk obstruksi usus, hernia insisional, pembedahan untuk insisional hernia dan nyeri perut.

2.1.7 Tatalaksana Pasien *Post* SC

Menurut Roberia (2019), ketika terdapat pasien *post*-SC, maka terdapat beberapa tindakan yang biasa dilakukan petugas kesehatan atau medis, antara lain: memeriksa tanda-tanda vital (TTV), analgesia, vesika urinarus dan usus, ambulasi, terapi cairan dan diet, laboratorium, perawatan luka, perawatan payudara dan pemulangan pasien.

2.2 Nyeri

2.2.1 Definisi

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan dimana hal itu terkait dengan adanya kerusakan jaringan yang sifatnya aktual atau potensial (Raja *et al.*, 2021). Pendapat sejenis juga disampaikan oleh Solehati *et al.* (2020) juga menyatakan bahwa nyeri pada dasarnya merupakan pengalaman ketidaknyamanan yang dirasakan orang secara subjektif, baik pengalaman itu bersifat sensorik atau pengalaman emosional, yang digambarkan sebagai suatu pengalaman yang merugikan orang yang mengalaminya.

2.2.2 Etiologi Nyeri *Post SC*

Pasien *post-SC* biasanya akan mengalami nyeri dengan intensitas yang berbeda pada masing-masing orang, mulai dari ringan hingga berat. Penyebab terjadinya nyeri pada pasien *post-SC* adalah karena akibat adanya robekan atau sayatan pada jaringan kontinuitas perut depan. Karena itu, pasien akan merasakan nyeri pada daerah insisi atau robekan (Febriantri and Machmudah, 2021). Pada saat pasien dilakukan operasi SC, biasanya terlebih dahulu akan diberikan obat anastesi. Kemudian dilakukan operasi SC. Saat pengaruh anastesi itu masih ada, maka pasien biasanya tidak akan merasakan nyeri sekalipun tindakan operasi sudah dilakukan. Namun, ketika pengaruh obat anastesi tersebut hilang, maka nyeri akan mulai dirasakan oleh pasien. Pasien yang mengalami nyeri biasanya akan menemui masalah dalam melakukan mobilisasi (Wahyu and Lina, 2019).

2.2.3 Patofisiologi Nyeri *Post SC*

Perjalanan penyakit atau patofisiologi nyeri pada pasien *post-SC* yaitu mula-mula SC dilakukan sebagai akibat dari terdapatnya kelainan pada janin atau ibu. Tindakan SC tersebut merupakan tindakan alternatif persalinan karena indikasi kelainan tersebut. Anastesi yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan dengan SC akan menyebabkan pasien mengalami imobilisasi, sehingga hal itu menyebabkan timbulnya masalah intoleransi aktivitas. Efek anastesi tersebut juga bisa menyebabkan otot mengalami relaksasi dan konstipasi. Selanjutnya, tindakan pembedahan pada pasien SC akan menyebabkan terdapatnya insisi atau robekan pada

dinding abdomen, sehingga hal itu akan menyebabkan inkontinuitas jaringan, pembuluh darah dan saraf-saraf di sekitar lokasi insisi menjadi terputus. Kondisi ini akan merangsang pengeluaran postaglandin dan histamin dimana hal itu bisa menimbulkan nyeri (akut). Ketika proses pembedahan SC selesai dilakukan, maka lokasi insisi akan ditutup kembali dan menimbulkan luka dimana bila hal itu tidak diatasi dengan baik akan menyebabkan timbulnya infeksi (Solehati *et al.*, 2020).

2.2.4 Tanda dan Gejala Nyeri

Menurut Purwoto *et al.* (2023), tanda atau indikator yang umum terjadi pada seseorang yang sedang mengalami nyeri antara lain:

1. Suara meringis, merintih, menarik atau menghembuskan nafas;
2. Ekspresi wajah meringis;
3. Menggigit bibir dan lidah, mengatupkan gigi, dahi berkerut, tertutup rapat atau membuka mata atau mulut;
4. Pergerakan tubuh tampak gelisah, mondar-mandir, gerakan menggosok atau berirama, bergerak melindungi bagian tubuh, immobilisasi dan otot tegang; dan
5. Interaksi sosial menghindari percakapan dan kontak sosial, berokus pada aktivitas untuk mengurangi nyerinya dan disorientasi waktu.

2.2.5 Klasifikasi Nyeri

Jika dilihat dari durasinya, nyeri bisa dikalsifikasikan menjadi akut dan kronis.

1. Nyeri akut adalah pengalaman nyeri yang dirasakan seseorang dimana hal itu timbul secara mendadak dan cepat menghilang dimana berlangsungnya tidak lebih dari 6 bulan dan ditandai dengan terjadinya peningkatan tegangan otot.
2. Nyeri kronis adalah nyeri yang berlangsung selama enam bulan atau lebih (Kemenkes, 2022).

2.2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nyeri *Post SC*

Menurut Suastini and Pawestri (2021), ibu yang telah melakukan persalinan dengan SC bisanya akan mengalami nyeri. Selanjutnya sensasi nyeri yang dirasakan pasien *post SC* akan memunculkan persepsi nyeri. Persepsi tiap individu terhadap nyeri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Kebudayaan
4. Gaya coping
5. Makna nyeri
6. Perhatian
7. Ansietas
8. Kelelahan
9. Pengalaman nyeri sebelumnya
10. Dukungan keluarga dan sosial.

2.2.7 Komplikasi Nyeri *Post SC*

Nyeri akut *post-SC* yang tidak segera ditangani secara cepat, tepat dan adekuat, maka akan berdampak pada *Activity Daily Living* (ADL) atau aktivitas sehari-hari dan mobilisasi ibu (mobilitas ibu menjadi terbatas), sehingga hal itu akan berpengaruh pada kurangnya perawatan atas bayi yang baru saja dilahirkan (Kristiani and Lathifah, 2019). Pendapat lain sejenis menyatakan bahwa komplikasi yang mungkin terjadi ketika nyeri *post SC* tidak segera diatasi secara adekuat, yaitu terbatasnya mobilisasi fisik ibu dan timbulnya beberapa komplikasi bagi pasien seperti halnya meningkatnya morbiditas, menurunnya kualitas dan fungsi hidup dan meningkatnya keterlambatan durasi atau waktu pemulihan (Kintu *et al.*, 2019).

2.2.8 Tatalaksana Nyeri *Post SC*

Menurut Sumarni *et al.*, (2019), penatalaksanaan nyeri pada pasien yang telah melakukan persalinan *SC* bisa secara farmakologis (obat-obatan) ataupun non-farmakologis (seperti aromaterapi, relaksasi dan sejenisnya).

2.2.9 Pengukuran Nyeri

Ada banyak cara pengukuran nyeri pada pasien yang mengalaminya, antara lain: *Verbal Descriptor Scale* (VDS), *Numerical Rating Scale* (NRS), *Visual Analog Scale* (VAS), *Face, Leg, Activity, Cry, Consolability* (FLACC), dan seterusnya (University of Florida Health, 2019). Hanya saja,

peneliti akan menejaskan salah satu di antaranya yang akan peneliti gunakan di dalam penelitian ini, yaitu *Numerical Rating Scale* (NRS).

Pengukuran nyeri melali NRS dilakukan melalui sebuah garis horizontal di mana garis tersebut dibagi menajdi 10 segmen dari angka 0 - 10. Saat seorang peneliti hendak melakukan pengukuran nyeri pada pasien dewasa, maka pasien akan diberi tahu bahwa angka 0 = tidak ada nyeri sama sekali, 1-3 = nyeri ringan, 4-6 = nyeri sedang, 7-10 = nyeri hebat . Di dalam proses pengukurannya, pasien diminta untuk melakukan penandaan pada angka yang dianggap paling tepat untuk menggambarkan rasa nyeri yang dirasakannya di dalam satu waktu (Ningtyas *et al.*, 2023).

2.3 Aromaterapi

2.3.1 Definisi

Aromaterapi merupakan terapi non-farmakologis dan komplementer serta alternatif dari minyak esensial yang berasal dari tanaman alami untuk relaksasi dan untuk mengendalikan pikiran serta tubuh melalui senyawa yang aromatik yang dikandungnya (Tabatabaeichehr and Mortazavi, 2020). Hal senada juga disampaikan Bertone and Dekker (2021) bahwa yang dimaksud dengan aromaterapi adalah penggunaan minyak tumbuhan aromatik yang sangat pekat di mana hal itu diberikan dengan berbagai cara untuk berbagai indikasi terapeutik.

Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan aromaterapi adalah penggunaan minyak aromatik yang berasal dari tetumbuhan dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan dan

kebugaran bagi berbagai jenis indikasi terapeutik yang dilakukan melalui kulit dan penciuman (inhalasi).

2.3.2 Bentuk-Bentuk Sediaan Aromaterapi

Menurut Sofiani and Pratiwi (2021), ada sejumlah bentuk sediaan dari aromaterapi yang selama ini beredar di pasaran, antara lain: *esensial oil*, parfum, lilin aromaterapi, gel aromaterapi, dupa, krim gosok atau pijat, dan sabun mandi. Berikut penjelasannya:

1. *Esensial Oil*, merupakan salah satu jenis aromaterapi yang bentuknya berupa minyak atau cairan. Komponen dari minyak esensial ini akan cepat mengalami interaksi saat dihirup, karena senyawa yang dikandungnya akan berinteraksi dengan sistem saraf pusat dan akan merangsang sistem alfaktori (saraf kranial). Minyak esensial ini biasanya banyak digunakan sebagai bahan campuran untuk produksi parfum, gel, lilin, krim dan sejenisnya.
2. Parfum, merupakan produk campuran antara minyak esensial dengan senyawa aroma, fiksatif serta pelarut yang biasa digunakan untuk menghasilkan bau wangi bagi tubuh, pakaian atau objek lainnya.
3. Lilin aromaterapi, merupakan benda padat yang apabila dibakar akan bisa memberikan penggunaanya ketenangan, karena mengandung berbagai minyak esensial tergantung masing-masing produknya.
4. Gel aromaterapi, merupakan salah satu jenis sediaan semi solid yang pada dasarnya bisa digunakan untuk kulit atau ruangan.

5. Dupa, salah satu produk yang dihasilkan dari campuran minyak astiri atau minyak esensial dengan serbuk-serbuk zat aktif di mana bentuknya berupa *stick* ataupun *cone*.
6. Krim pijat, merupakan produk yang dihasilkan dari minyak astiri atau minyak esensial sekitar 2% dan bahan lainnya yang menjadi basis dalam pembuatan krim.
7. Garam aromaterapi, merupakan suatu produk yang biasa digunakan untuk bahan mandi di mana biasanya produk ini digunakan di tempat spa ataupun di rumah. Penggunaannya biasanya dengan mengambil beberapa sendok dan dicampurkan dengan air hangat yang akan digunakan untuk mandi.
8. Sabun, merupakan produk yang biasa digunakan untuk mandi sebagaimana halnya garam aromaterapi dengan tujuan untuk menghilangkan bakteri dan memberikan rasa segar.

2.3.3 Macam-Macam Minyak Esensial Aromaterapi

Ada sejumlah minyak esensial yang biasa digunakan sebagai aromaterapi, antara lain: Eukaliptus (*Eucalyptus Globulus*), Langon Kleri (*Slavia Scarea*), Granium (*Pelargonium Graveolens*), Lemon (*Citrus Limonem*), Lavender (*Lavendula Vera Officinals*), Pappermint (*Mentha Piperita*), Pettigrain (*Citrus Aurantium*), Rosmari (*Rosmarinus Officinals*), dan Pohon Teh (*Melalueca Alternifolia*). Itulah beberapa macam minyak esensial yang banyak digunakan sebagai aromaterapi untuk

menurunkan nyeri atau kecemasan yang banyak beredar di pasaran. Minyak esensial lavender dan lemon adalah yang paling banyak digunakan sebagai terapi berbagai keluhan (Muchtaridi and Moelyono, 2021).

2.3.4 Aromaterapi Lavender

Aromaterapi lavender berarti penggunaan minyak esensial sebagai suatu terapi yang berasal jenis tanaman bunga lavender. Bunga lavender pada dasarnya memiliki 25 hingga 30 spesies di mana beberapa spesies di antaranya antara lain: *lavandula angustifolia*, *lavandula stoechas* dan *lavandula lantifolia*. Tumbuhan ini berasal dari wilayah Laut Tengah sampai Afrika tropis dan Timur sampai India. Bahkan tanaman ini juga menyebar ke berbagai wilayah seperti kawasan Afrika Utara dan Timur, Arabia dan Eropa Selatan serta Mediterania (Rahman, 2021).

Bunga lavender dapat diproduksi sebagai minyak atau parfum. Manfaat dari minyak lavender ini dapat digunakan sebagai minyak esensial sebagai aromaterapi karena manfaatnya bisa menghasilkan relaksasi dan efek sedasi yang bermanfaat bagi orang dengan insomnia. Hal itu karena kandungan utama yang terdapat dalam minyak lavender ini adalah linalyl asetat dan linalool di mana memiliki efek relaksasi (McClain dalam Rahman, 2021). Selain itu, wangi yang dihasilkan minyak lavender bisa berfungsi sebagai penghilang rasa sakit. Hal itu karena wangi yang dihasilkan bisa mengeluarkan enkefalin yang pada dasarnya merupakan neuromodulator untuk menghambat nyeri fisiologis (Juliani *et al.*, 2021).

2.3.5 Prosedur Pemberian Aromaterapi

Mekanisme pemberian aromaterapi dari minyak esensial adalah dengan cara diberikan selama 30 menit kepada pasien selama 1-3 hari dengan frekuensi 1 kali setiap hari (Nurhasanah, 2022). Hal itu karena penyerapan sepenuhnya minyak tersebut ke dalam sistem sirkulasi tubuh membutuhkan waktu selama 30 menit sebelum dikeluarkan kembali melalui paru-paru, kulit ataupun urin beberapa jam kemudian (Santriwati, 2019). Rohimah and Utami (2021) menyatakan bahwa pemberian aromaterapi pada pasien yang mengalami nyeri pasca-persalinan, baik secara normal atau secara sesar, bisa dilakukan dengan cara mencampurkan 5-8 tetes minyak esensial ke dalam 200 ml air menggunakan diffuser elektrik selama 30-45 menit. Setelah itu dilakukan observasi atas nyeri yang dirasakan pasien.

2.4 Mekanisme Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri

Post SC

Secara umum, aromaterapi, termasuk aromaterapi Lavender, bisa mempengaruhi terjadinya perubahan nyeri *post-operasi*, termasuk nyeri *post-SC*, karena secara teoritis, aroma yang segar dan harum dari aromaterapi tersebut akan memberikan efek yang kuat pada emosi. Prosesnya yaitu mula-mula aroma dari aromaterapi akan ditangkap oleh hidung. Kemudian hidung akan menyampaikan informasinya secara lebih jauh kepada otak sebagai pengontrol emosi dan memori. Otak selanjutnya akan melanjutkan informasi yang ditangkap kepada hipotalamus yang berfungsi sebagai pengatur sistem di

internal tubuh, suhu tubuh, sistem seksualitas dan reaksi atas stres yang terjadi. Efek lain yang ditimbulkan oleh aromaterapi adalah relaksasi dan dapat mengurangi rasa nyeri serta mengurangi kecemasan. Ketika seseorang diberikan aromaterapi, maka efek yang dirasakan seseorang akan merasa jauh lebih baik dari sebelumnya (Tirtawati *et al.*, 2020).

Secara lebih khusus, aroma terapi Lavender bisa mempengaruhi nyeri post-SC, karena aromaterapi Lavender mampu memberikan rileks dan nyaman pada tubuh dengan kandungan *linalyl asetat* dan *linalool* (C₁₀H₁₈O). Senyawa *linalyl asetat* berfungsi melonggarkan sistem kerja saraf otot yang sedang dalam kondisi tegang. Sementara senyawa *linalool* memiliki manfaat sebagai efek relaksasi dan *sedative*, sehingga mampu menurunkan nyeri, termasuk nyeri *post SC* (Rahmayani and Machmudah, 2022).

2.5 Penelitian Terdahulu

Letak keberbedaan suatu penelitian satu dengan yang lainnya bisa dilihat dari berbagai aspek, antara lain: lokasi penelitian, subjek atau responden, variabel, dan sejenisnya. Penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan berbeda dengan penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti & Judul	Variabel	Desain	Sampel	Instrumen	Teknik Analisis Data
Herawati (2022). Efektivitas Kombinasi Pemberian Aromaterapi Lavender dan Distraksi Terapi Musik Klasik	Independen: Kombinasi Pemberian Aromaterapi Lavender dan Distraksi Terapi Musik Klasik (Mozart)	<i>Quasy-Experiment Non-Equivalent Control Group</i>	30 ibu yang melahirkan secara SC (dibagi 2 kelompok yaitu: 15 orang untuk kelompok intervensi menerima	<i>Numeric Rating Scale (NRS)</i>	<i>Wilcoxon Signed Rank Test dan Mann Withney</i>

(Mozart) terhadap Penurunan Intensitas Skala Nyeri pada Ibu <i>Post Sectio Caesarea</i>	Dependen: Penurunan Intensitas Skala Nyeri pada Ibu <i>Post Sectio</i>		terapi kombinasi lavender dan distraksi musik klasik Mozart & 15 orang untuk kelompok kontrol menerima terapi relaksasi nafas dalam.		
Anggraeni et al. (2021). <i>The Impact of Combination Therapy Utilizing Citrus Limon Aromatherapy and Mozart Classical Music Distraction Therapy to Reduce the Pain Intensity in Post-Sectio Caesarean Mothers</i>	Independen: <i>Combination Therapy Utilizing Citrus Limon Aromatherapy and Mozart Classical Music</i> Dependen: <i>Reducing the Pain Intensity in Post-Sectio Caesarean Mothers</i>	Quasy-Experiment Non-Equivalent Control Group	30 ibu yang melahirkan secara SC (dibagi 2 kelompok, yaitu: 15 orang untuk kelompok intervensi menerima terapi kombinasi aromaterapi Citrus Limon musik klasik Mozart & 15 orang kelompok kontrol menerima terapi latihan nafas dalam)	Numeric Rating Scale (NRS)	Wilcoxon Signed Rank Test dan Mann Withney
Sanjaya et al. (2023). <i>Effectiveness of Lavender Aromatherapy on Caesarean Postoperative Pain</i>	Independen: <i>Lavender Aromatherapy</i> Dependen: <i>Caesarean Postoperative Pain</i>	Quasy-Experiment Non-Equivalent Control Group	30 wanita yang telah melahirkan secara SC (dibagi 2 kelompok, yaitu 15 orang untuk kelompok intervensi diberi terapi aromaterapi Lavender dan relaksasi nafas dalam & 15 orang untuk kelompok kontrol	Numeric Rating Scale (NRS)	Mann Whitney

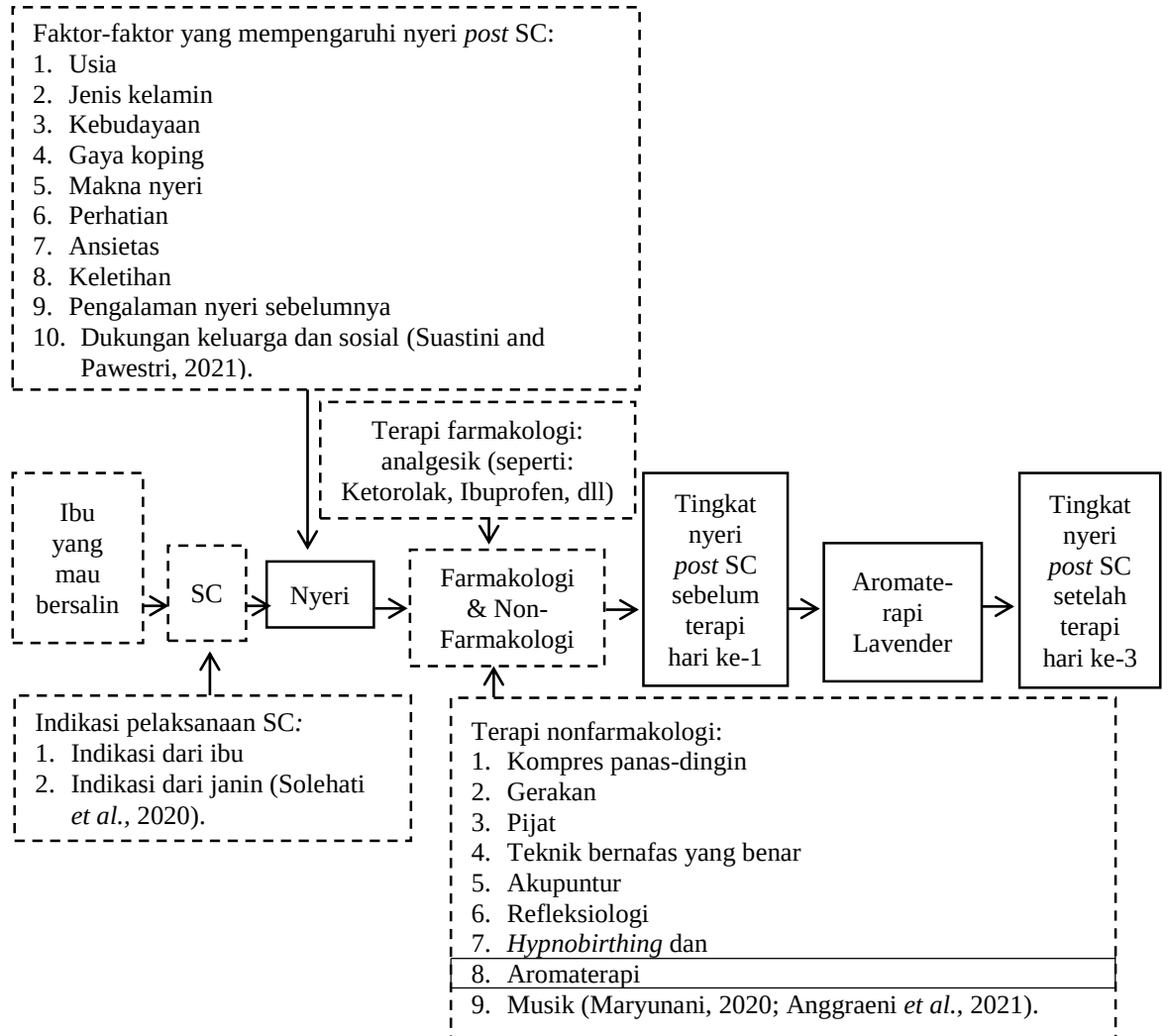
			diberi terapi relaksasi nafas dalam saja)		
Abdraboo <i>et al.</i> (2020). <i>Effectiveness of Inhalation of Lavender Oil in Relieving Post-Caesarean Section Pain</i>	Independen: <i>Inhalation of Lavender Oil</i> Dependen: <i>Relieving Post-Caesarean Section Pain</i>	<i>Quasy-Experiment Non-Equivalent Control Group</i>	100 wanita postpartum yang melahirkan secara SC (dibagi 2 kelompok, yaitu: 50 orang untuk kelompok intervensi menerima terapi minyak lavender dan oksigen & 50 orang untuk kelompok kontrol menerima terapi oksigen saja).	<i>Visual Analog Scale (VAS)</i>	<i>Independent Sample T-Test</i>
Herawati <i>et al.</i> (2023). <i>Effectiveness of Lavender Aromatherapy on Reducing Pain Intensity after 24 Hours Post Sectio Caesarea</i>	Independen: <i>Lavender Aromatherapy</i> Dependen: <i>Reducing Pain Intensity after 24 Hours Post Sectio Caesarea</i>	<i>Quasy-Experiment One Group Pretest-Posttest</i>	40 wanita yang melahirkan secara SC	<i>Numerci Rating Scale (NRS)</i>	<i>Wilcoxon Signed Rank Test</i>

Beberapa hal yang memungkinkan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana tampak pada Tabel 2.1 di atas, umumnya terletak pada variabel yang diteliti, lokasi penelitian dan jumlah sampel, dan model jenis intervensi yang diberikan. Perbedaan-perbedaan itu memungkinkan penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

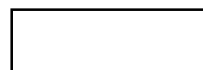
3.1 Kerangka Konsep



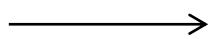
Keterangan:



: Variabel yang tidak diteliti



: Variabel yang diteliti



: Hubungan

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang

Input penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan SC dengan indikator yang bisa datang dari ibu atau dari janin dimana biasanya ibu yang melahirkan dengan metode tersebut akan merasakan nyeri *post* operasi (Solehati *et al.*, 2020). Nyeri *post* SC bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain: usia, jenis kelamin, kebudayaan, gaya coping, makna nyeri, perhatian, ansietas, kelelahan, pengalaman nyeri sebelumnya, dukungan keluarga dan sosial (Suastini and Pawestri, 2021). Kemudian, tingkat atau intensitas nyeri *post* SC tersebut secara teoritis bisa diintervensi melalui terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Salah satu jenis terapi non-farmakologis yang paling sering digunakan adalah aromaterapi (Lavender).

Secara teoritis, terapi tersebut dianggap mampu menurunkan tingkat nyeri yang dirasakan seseorang, termasuk nyeri *post* SC. Karena itu, agar penelitian ini bisa melakukan observasi atas tingkat nyeri *post* SC dan membandingkan rata-rata keduanya sehingga secara statistik bisa dinyatakan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap perubahan tingkat nyeri *post* SC, maka terapi tersebut akan menjadi suatu proses tata laksana dari penelitian eksperimen ini. Melalui terapi tersebut, maka *output* dari penelitian ini bisa dilihat, yaitu tingkat nyeri *post* SC yang menurun, stagnan atau malah meningkat.

3.2 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya (Nursalam, 2019). Hipotesis alternatif (H_a) penelitian ini, yaitu: ada pengaruh yang

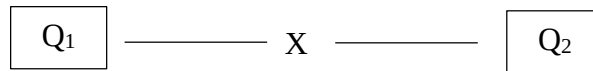
signifikan inhalasi aromaterapi Lavender terhadap perubahan nyeri pasien *post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian *Pre-Experimental* dengan rancangan *Pretest – Posttest One Group Design*, yaitu desain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil *pretest* dan *posttest* pada satu kelompok eksperimen penelitian. Karena itu, subjek penelitian akan dilihat tingkat nyeri *post* SC mereka sebelum dan setelah diberikan inhalasi aromaterapi Lavender. Sugiyono (2019) menggambarkan skema penelitian dengan desain *Pre-Experiment Pretest – Posttest One Group Design* seperti gambar berikut ini:



Gambar 4.1 Model Penelitian dengan *Pre-Experiment Pretest – Posttest One Group Design*

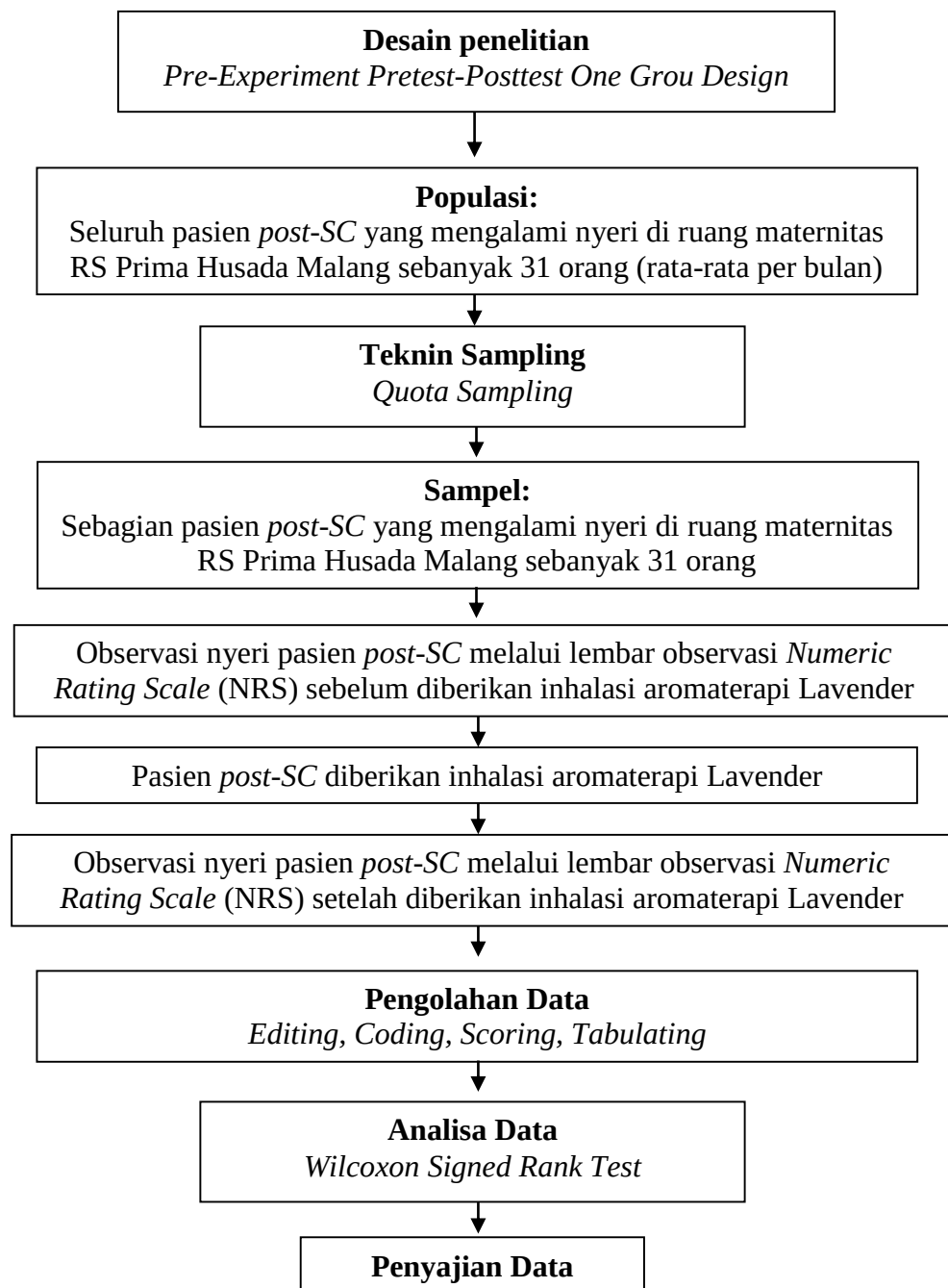
Keterangan:

- Q₁ : *Pretest* nyeri *post-SC* sebelum diberikan intervensi.
- X : Intervensi inhalasi aromaterapi Lavender.
- Q₂ : *Posttest* nyeri *post-SC* setelah diberikan intervensi.

4.2 Kerangka Kerja

Setiadi (2019) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerangka kerja (*frame-work*) dalam suatu penelitian adalah tahapan-tahapan atau langkah-

langkah yang ditempuh peneliti ketika melakukan pengumpulan data, sehingga tujuannya bisa dicapai. Bagan di bawah ini merupakan gambaran dari kerangka kerja atau langkah-langkah yang hendak peneliti tempuh dalam proses penelitian ini:



Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang

4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

4.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dalam rangka untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Artinya, populasi penelitian ini seluruh pasien *post* SC di ruang maternitas RS Prima Husada Malang. Populasi dalam penelitian ini belum diketahui dengan pasti. Karena penelitian ini rencananya akan dilakukan pada bulan April 2024 mendatang di ruang maternitas RS Prima Husada Malang. Hanya saja, jika merujuk pada berdasarkan keterangan kepala ruangan ruang maternitas pada 3 Oktober 2023 lalu, rata-rata jumlah pasien *post*-SC sebanyak 31 orang.

4.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang ditentukan oleh seorang peneliti berdasarkan kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2019). Artinya, sampel penelitian ini merupakan sebagian pasien *post* SC di ruang maternitas RS Prima Husada Malang yang berjumlah sebanyak 31 orang (berdasarkan rata-rata jumlah pasien *post*-SC tiap bulan di ruang maternitas). Hanya saja, jumlah tersebut bisa berubah sesuai dengan jumlah pasti pasien di lapangan saat penelitian dilakukan nanti pada bulan April 2024. Sampel tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria inklusi

- a. Pasien *post* SC yang dirawat di ruang maternitas RS Prima Husada Malang;
- b. Pasien *post* SC yang dalam kondisi sadar (*compos mentis*); dan
- c. Pasien *post* SC yang dirawat di ruang maternitas selama 3 hari.

2. Kriteria eksklusi

- a. Pasien *post* SC tidak kooperatif;
- b. Pasien *post* SC yang mengalami gangguan penciuman atau alergi aromaterapi;
- c. Pasien *post* SC yang mengalami gangguan pendengaran; dan
- d. Pasien *post* SC yang tidak menyukai aromaterapi Lavender.

4.3.3 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan cara seorang peneliti dalam menentukan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik *Quota Sampling*. Sugiyono (2019) mendefinisikan *Quota Sampling* sebagai cara menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan.

4.4 Variabel

4.4.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab atau variabel yang dapat mempengaruhi perubahan pada variabel dependen

(Sugiyono, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini adalah “inhalasi aromaterapi Lavender”.

4.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dinilainya ditentukan oleh variabel lain atau variabel independen (Sugiyono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah “perubahan nyeri pasien *post SC*”.

4.5 Definisi Operasional

Variabel penelitian perlu didefinisikan secara operasional agar tidak terjadi kesesatan dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Tabel berikut ini merupakan definisi operasional atas variabel penelitian ini:

Tabel 4.1 Definisi Operasional Penelitian Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Alat Ukur	Skala Data	Hasil Ukur
1	Aromaterapi lavender	Penggunaan minyak esensial yang berasal dari tumbuhan (bunga lavender) dengan cara inhalasi (dihirup melalui hidung).	a. Menggunakan media <i>diffuser</i> elektrik yang diisi air 10 cc; b. Minyak esensial lavender ditetaskan sebanyak 4-5 tetes; c. <i>Diffuser</i> elektrik dinyalakan dan mengeluarkan uap; d. Uap dihirup selama 30 menit.	SOP	-	-
2	Perubahan nyeri pasien <i>post-sectio caesarea</i>	Perubahan kondisi tidak menyenangkan yang dirasakan secara subjektif oleh seseorang pasca melakukan operasi sesar dengan	a. 0 = tidak ada rasa sakit/nyeri. Merasa normal; b. 1 = Nyeri hampir tidak terasa (sangat ringan) seperti gigitan nyamuk; c. 2 = tidak menyenangkan atau nyeri ringan seperti	Lembar observasi <i>Numeric Rating Scale</i> (NRS)	O R D I N A L	1. Tidak nyeri (0); 2. Nyeri ringan (1-3); 3. Nyeri sedang (4-6); 4. Nyeri hebat (7-9); dan

melihat hasil tes nyeri post SC sebelum dan setelah diberikan aromateapi lavender yang diukur dengan <i>Numeric Rating Scale</i> (NRS).	cubitan ringan pada kulit; d. 3 = nyeri bisa ditoleransi meskipun sangat terasa seperti suntikan dokter; e. 4 = nyeri kuat/dalam seperti sakit gigi atau sengatan lebah; f. 5 = nyeri kuat, dalam dan menusuk seperti terkilirnya pergelangan kaki; g. 6 = nyeri yang intens, kuat, dalam dan menusuk begitu kuat sehingga bisa mempengaruhi sebagian indra pasien dan menyebabkannya tidak fokus atau komunikasi terganggu; h. 7 = nyeri sangat intens sama seperti 6 kecuali bahwa rasa sakit benar-benar mendominasi indra pasien yang menyebabkannya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak mampu melakukan perawatan diri; i. 8 = nyeri benar-benar mengerikan dan begitu kuat, sehingga pasien tidak bisa berpikir jernih dan sering mengalami perubahan kepribadian yang parah jika sakit datang dan berlangsung lama; j. 9 = nyeri yang menyiksa dan tidak tertahankan, sehingga pasien tidak bisa mentolerirnya dan sampai menuntut untuk segera menghilangkan rasa sakit apapun caranya, tidak peduli efek samping atau risikonya;	5. Nyeri sangat hebat (10) (Ningtyas <i>et al.</i> , 2023).
---	---	---

-
- k. 10 = nyeri yang tidak terbayangkan dan tidak dapat diungkapkan dan pasien tidak sadarkan diri (Ningtyas *et al.*, 2023).
-

4.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilakukan di ruang maternitas RS Prima Husada Malang selama satu bulan April 2024.

4.7 Pengumpulan Data

4.7.1 Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang digunakan oleh seorang peneliti untuk melakukan pengumpulan data di dalam penelitiannya (Sugiyono, 2019). Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu lembar observasi *Numeric Rating Scale* (NRS) baku sebagaimana ditetapkan oleh *College of Medicine Jacksonville* sebagai alat ukur tingkat nyeri pada pasien dewasa. Lembar observasi ini merupakan rancangan alat ukur untuk melihat tingkat atau skala nyeri seseorang, termasuk nyeri *post SC*, di mana gambarannya berbentuk garis horizontal (pada ujung sebelah kiri menunjukkan angka 0 yang berarti tidak ada nyeri dan ujung sebelah kanan menunjukkan angka 10 yang berarti nyeri sangat hebat). Semakin kecil angka yang dihasilkan dalam proses observasi, maka tingkat nyerinya juga akan semakin kecil dan juga sabaiknya.

Lembar observasi ini akan diisi oleh responden penelitian. Dalam responden tersebut, responden diminta menandai tingkat nyeri *post SC*

yang dirasakannya dari skala 0-10. Adapun tolak ukur yang ditetapkan oleh instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak nyeri (angka 0);
2. Nyeri ringan (angka 1-3);
3. Nyeri sedang (angka 4-6);
4. Nyeri berat (angka 7-9); dan
5. Nyeri sangat hebat (angka 10) (Ningtyas *et al.*, 2023).

4.7.2 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dua tahap, antara lain:

1. Persiapan
 - a. Peneliti mengurus surat pengantar dari kampus STIKES Husada Jombang untuk pengambilan data di RS Prima Husada Malang;
 - b. Peneliti mengurus surat izin pengambilan data awal di RS Prima Husada Malang;
 - c. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian, manfaat, serta prosedur penelitian kepada responden;
 - d. Peneliti meminta kesediaan pasien *post* SC untuk menjadi responden;
 - e. Jika bersedia, maka responden diminta menandatangani *informed consent* sebagai bukti kesediannya untuk menjadi responden penelitian;

- f. Peneliti menyiapkan peralatan untuk pemberian intervensi inhalasi aromaterapi Lavender kepada responden; dan
- g. Peneliti menyiapkan lembar observasi tingkat nyeri untuk pasien *post-SC*.

2. Pelaksanaan

- a. Peneliti melakukan observasi tingkat nyeri pada 31 pasien *post SC* sebelum diberikan intervensi inhalasi aromaterapi Lavender di hari ke-1.
- b. Peneliti memberikan intervensi inhalasi aromaterapi Lavender selama 30 menit pada 31 pasien *post SC* di hari ke 1 - 3 dengan dosis sebanyak 4-5 tetes minyak esensial Lavender yang dicampur dengan 10 cc air dan intervensi tersebut dimulai 6 jam setelah pasien diberikan terapi farmakologi (analgesik).
- c. Peneliti melakukan observasi tingkat nyeri pada 31 pasien *post SC* setelah diberikan intervensi inhalasi aromaterapi Lavender di hari ke-3.

4.8 Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini melalui beberapa tahap, antara lain:

1. *Editing*. Proses *editing* dimaksudkan untuk memeriksa kembali apakah pada masing-masing responden (pasien *post-SC*) telah didapatkan data berupa tingkat nyeri *post SC* atau tidak. Selain itu, *editing* ini dimaksudkan apakah responden telah mengisi secara lengkap lembar observasi data demografi

atau tidak. Jika tidak, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali.

2. *Coding*. Proses *coding* dalam penelitian dimaksudkan agar data penelitian bisa dikalkulasi oleh aplikasi *SPSS v.25 for Windows*, sehingga peneliti tidak melakukan analisis data secara manual. Adapun proses *coding* dalam penelitian ini, yaitu:

Umur:

Kode 1 untuk remaja akhir (17 – 25 tahun)

Kode 2 untuk dewasa awal (26 – 35 tahun)

Kode 3 untuk dewasa akhir (36 – 45 tahun).

Pendidikan terakhir:

Kode 1 untuk SD/ sederajat

Kode 2 untuk SMP/ sederajat

Kode 3 untuk SMA/ sederajat

Kode 4 untuk perguruan tinggi (D3/S1-S3).

Pekerjaan:

Kode 1 untuk karyawan swasta

Kode 2 untuk PNS/TNI/Polri

Kode 3 untuk petani

Kode 4 untuk pedagang

Kode 5 untuk lain-lain.

Riwayat Bersalin:

Kode 1 untuk sesar (SC)

Kode 2 untuk persalinan normal.

Riwayat Kehamilan

Kode 1 untuk kehamilan ke-1

Kode 2 untuk kehamilan ke-2

Dst...

Tingkat Nyeri *Post SC*:

Kode 1 untuk tidak nyeri (angka 0)

Kode 2 untuk nyeri ringan (angka 1-3)

Kode 3 untuk nyeri sedang (angka 4-6)

Kode 4 untuk nyeri berat (angka 7-9)

Kode 5 untuk nyeri sangat hebat (10).

3. *Scoring*. Proses *scoring* yang dimaksud adalah peneliti memberikan skor atas skala nyeri yang dirasakan responden berdasarkan hasil observasi melalui lembar observasi NRS yang tersedia.
4. *Tabulating*. Proses *tabulating* dimaksudkan agar peneliti menyusun data yang sudah terkumpul ke dalam satu tabel yang memuat data keseluruhan responden. maksudnya peneliti melakukan penyusunan kode dan skor dalam satu tabel. Tabel yang dimaksud adalah tabel dari *Microsoft Excel*. Proses ini dilakukan agar peneliti mudah melakukan input data ke dalam aplikasi *SPSS v.25 for Windows*.

4.9 Analisa Data

Analisa data univariat pada penelitian ini merupakan analisa data yang akan menghasilkan formulasi data berupa frekuensi dan persentase untuk data demografi dan formulasi data berupa rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan

standar deviasi (SD) untuk nyeri *post* SC. Selanjutnya, analisa data bivariat penelitian ini akan menggunakan uji *Wilcoxon Sign Rank Test*. Uji non-parametrik ini digunakan untuk mencari pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini digunakan pada penelitian ini karena skala data berbentuk kategorik/ordinal (Dahlan, 2019). Interpretasi dari uji tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika $P\text{-value} < 0,05$, maka ada pengaruh signifikan inhalasi aromaterapi Lavender terhadap perubahan nyeri pasien *post* SC; dan
2. Jika $P\text{-value} > 0,05$, maka tidak ada pengaruh signifikan inhalasi aromaterapi Lavender terhadap perubahan nyeri pasien *post* SC.

4.10 Etika Penelitian

Peneliti telah mendapatkan izin *ethical clearance* dari Komite Etik Keperawatan STIKES Husada Jombang dengan nomor 0544-KEPKSHJ dan dinyatakan layak sesuai dengan 7 standar etik WHO 2011. Adapun 7 standar etik penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Informed Consent*. Maksudnya, sebelum peneliti melakukan pengambilan data, maka terlebih dahulu meminta persetujuan kesediaan calon responden untuk terlibat dalam penelitian. Hal itu bisa dilakukan dengan mengisi lembar persetujuan (*informed consent*). Jika dalam prakteknya calon responden menolak berpartisipasi, maka peneliti harus menerima dan menghormati keputusannya.
2. *Social values*. Maksudnya, penelitian ini akan memberikan nilai sosial yaitu potensial untuk memberikan informasi yang valid bagi masyarakat luas.

3. *Scientific value*. Maksudnya, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan standar nilai ilmiah mulai dari desain, penentuan sampel, instrumen yang digunakan dan seterusnya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan temuan yang bersifat ilmiah pula.
4. *Equitable assesment and benefits*. Maksudnya, penelitian ini mengharuskan peserta atau subjek penelitian diambil dengan kualifikasi suatu populasi pada wilayah geografis yang hasilnya bisa diterapkan. Salah satu kriterianya adalah pemilihan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan tidak pada status sosial-ekonomi.
5. *Risk*. Maksudnya, penelitian ini dilakukan tanpa menimbulkan resiko yang membahayakan secara medis kepada subjek penelitian.
6. *Convidentiality and privacy*. Maksudnya, penelitian ini harus menjamin kerahasiaan data yang didapatkan dari responden. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, peneliti tidak boleh menunjukkan nama asli responden di dalam kuesioner. Nama responden harus diganti dengan kode tertentu. Hal ini untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data responden.
7. *Beneficence dan non-maleficence*. Maksudnya, seorang peneliti harus berbuat baik dan tidak merugikan responden saat pengumpulan data.

4.11 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu terapi yang diberikan (aromaterapi Lavender) memang dilakukan selama 3 hari. Hanya saja dengan frekuensi satu kali sehari. Idealnya penelitian melakukan terapi selama 2-3 hari

dengan frekuensi 2 kali sehari (pagi dan sore). Hal itu dilakukan atas permintaan RS (RS Prima Husada Malang) agar keberadaan pasien tidak merasa terganggu. Namun demikian, proses terapi yang diberikan kepada responden sudah dilakukan dengan benar sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Kemudian, penelitian ini juga tidak melakukan identifikasi pada aspek gangguan depresi dan kecemasan responden sebelum proses operasi yang dijadikan sebagai salah satu argumentasi faktor yang beresiko yang kemungkinan berpengaruh pada tingkat nyeri *post-SC* responden sebelum diberikan terapi inhalasi aromaterapi Lavender. Meskipun demikian, peneliti telah melakukan *literature review* terhadap sejumlah literatur penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan (April-Mei 2024). Penelitian ini dilakukan secara mandiri dengan beberapa kali dibantu enumerator. Penelitian ini pertama-tama dilakukan dengan mengobservasi skala nyeri responden (pasien *post-SC*) menggunakan lembar observasi *Numeric Rating Scale* (NRS) sebelum diberikan inhalasi aromaterapi Lavender. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian intervensi tersebut selama 30 menit pada 31 pasien *post SC* di hari ke 1 - 3 dengan dosis sebanyak 4-5 tetes minyak esensial Lavender yang dicampur dengan 10 cc air yang dimulai pada 6 jam setelah pasien diberikan terapi farmakologi (analgesik). Selanjutnya, ketika intervensi di hari ke-3 selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan mengobservasi skala nyeri responden menggunakan lembar observasi yang sama setelah diberikan inhalasi aromaterapi Lavender. Hal itu dilakukan pada 31 responden penelitian. Data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis secara univariat dan bivariat. Berikut hasil yang didapatkan:

5.1.1 Data Umum (Data Demografi Responden)

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Kategori	Frekuensi	Persentase
≤ 20 tahun	0	0
21-25 tahun	7	22.6
26-30 tahun	14	45.2
> 30 tahun	10	32.3
Total	31	100

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa hampir setengah responden berumur dalam kategori 26-30 tahun sebanyak 14 orang (45.2%).

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat

Kategori	Frekuensi	Persentase
Blimbing	11	35.5
Singosari	10	32.3
Lawang	8	25.8
Karangploso	2	6.5
Total	31	100

Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa hampir setengah responden beralamat di Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang sebanyak 11 orang (35.5%).

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Kategori	Frekuensi	Persentase
SD/Sederajat	0	0
SMP/Sederajat	2	6.5
SMA/Sederajat	9	29.0
Perguruan Tinggi (D3/S1-S3)	20	64.5
Total	31	100

Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan pada level perguruan tinggi (D3/S1-S3) sebanyak 20 orang (64.5%).

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Karyawan Swasta	8	25.8
PNS/TNI/Polri	1	3.2
Pedagang	3	9.7
IRT	16	51.6
Perawat	2	6.5
Guru	1	3.2
Total	31	100

Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden bekerja sebagai IRT sebanyak 16 orang (51.6%).

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Bersalin

Tabel 5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Bersalin

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sesar	26	83.9
Normal	2	6.5
Tidak ada	3	9.7
Total	31	100

Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki riwayat bersalin secara sesar sebanyak 26 orang (83.9%).

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Kehamilan

Tabel 5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Kehamilan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Kehamilan ke-1	3	9.7
Kehamilan ke-2	28	90.3
Total	31	100

Tabel 5.6 di atas menunjukkan mayoritas responden merupakan pasien *post*-SC dengan kehamilan ke-2 sebanyak 28 orang (90.3%).

5.1.2 Data Khusus

1. Hasil Identifikasi Skala Nyeri Pasien *Post* SC di RS Prima Husada Malang setelah Diberikan Inhalasi Aromaterapi Lavender

Tabel 5.7 Hasil Identifikasi Skala Nyeri Pasien *Post* SC di RS Prima Husada Malang sebelum Diberikan Inhalasi Aromaterapi Lavender

Kategori	F	%	Min	Mak	Mean	SD
Tidak ada nyeri (0)	0	0				
Nyeri ringan (1-3)	1	3.2				
Nyeri sedang (4-6)	22	71	3.00	8.00	5.4839	1.26151
Nyeri berat (7-9)	8	25.8				
Nyeri Sangat Berat (10)	0	0				

Total	31	100
--------------	-----------	------------

Tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengeluh nyeri “sedang” sebanyak 22 orang (71%) sebelum diberikan inhalasi aromaterapi Lavender. Hal itu berdasarkan pengukuran nyeri menggunakan lembar observasi NRS. Selanjutnya, nilai minimum sebesar 3, maksimum sebesar 8, rata-rata (*mean*) sebesar 5.4839 (dibulatkan menjadi 5) dan standar deviasi (SD) sebesar 1.26151.

2. Hasil Identifikasi Skala Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang setelah Diberikan Inhalasi Aromaterapi Lavender

Tabel 5.7 Hasil Identifikasi Skala Nyeri Pasien *Post SC* di RS Prima Husada Malang setelah Diberikan Inhalasi Aromaterapi Lavender

Kategori	F	%	Min	Mak	Mean	SD
Tidak ada nyeri (0)	0	0				
Nyeri ringan (1-3)	19	61.3				
Nyeri sedang (4-6)	12	38.7	1.00	6.00	3.4839	1.23480
Nyeri berat (7-9)	0	0				
Nyeri Sangat Berat (10)	0	0				
Total	31	100				

Tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengeluh nyeri “ringan” sebanyak 19 orang (61.3%) setelah diberikan inhalasi aromaterapi lavender. Hal itu berdasarkan pengukuran nyeri menggunakan lembar observasi NRS. Selanjutnya, nilai minimum sebesar 1, maksimum sebesar 6, rata-rata (*mean*) sebesar 3.4839 (dibulatkan menjadi 3) dan SD sebesar 1.23480.

3. Hasil Analisis Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Skala Nyeri Pasien *Post* SC di RS Prima Husada Malang

Tabel 5.8 Hasil Analisis Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Skala Nyeri Pasien *Post* SC di RS Prima Husada Malang

Keterangan	Mean	Selisih Mean	P-value
Sebelum diberikan inhalasi aromaterapi Lavender	5.4839	2	0.000
Setelah diberikan inhalasi aromaterapi Lavender	3.4839		

Tabel 5.8 di atas merupakan hasil analisis *Wilcoxon Signed Rank Test* yang menunjukkan nilai signifikansi (*P-value*) sebesar $0.000 < 0.05$. Hal itu berarti bahwa ada pengaruh signifikan pemberian inhalasi aromaterapi lavender terhadap perubahan skala nyeri pasien *post* SC di RS Prima Husada Malang. Artinya, hipotesis alternatif dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Adanya pengaruh signifikan pemberian inhalasi aromaterapi lavender terhadap perubahan skala nyeri pasien *post* SC tersebut juga bisa dilihat dari perbandingan nilai *mean* (rata-rata) sebelum (5.4839) dan sesudah (3.4839). Hal itu menunjukkan terjadi penurunan rata-rata skala nyeri pada responden dengan selisih sebesar 2.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Skala Nyeri Pasien *Post* SC di RS Prima Husada Malang sebelum diberikan Inhalasi Aromaterapi Lavender

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden mengeluh nyeri *post*-SC “sedang” sebanyak 22 orang (71%) dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5.4839 (sedang) sebelum diberikan inhalasi

aromaterapi Lavender. Hal itu berdasarkan pengukuran nyeri menggunakan lembar observasi NRS. Faktor utama terjadinya nyeri pada pasien *post-SC* adalah terjadinya operasi atau bedah tersebut. Secara teoritis, operasi tersebut akan memberikan efek nyeri sebagai akibat dari kontinuitas jaringan dan pembedahan (Rini and Susanti, 2019). Pendapat sejenis lain menyatakan bahwa pasien *post-SC* biasanya memang mengalami nyeri pada daerah yang dioperasi sebagai akibat insisi atau sobekan pada jaringan kontuitas perut di bagian depan (Febriantri and Machmudah, 2021). Selain faktor tersebut, faktor utama lainnya yang kemungkinan besar mempengaruhi terjadinya nyeri pada pasien tersebut adalah habisnya reaksi atau efek obat anastesi epidural yang ditujukan untuk menghilangkan nyeri pada saat operasi dilakukan (Wahyu and Lina, 2019). Artinya, jika terjadi operasi atau jika pengaruh obat anastesi epidural habis, maka pasien pun akan mengalami perubahan jaringan kontuitas yang bisa menyebabkan nyeri. Karena itu, nyeri yang dirasakan pasien *post-SC* akan direspon secara variatif dengan berbagai macam gejala seperti mengerang, menagis, meringis, gelisah dan sejenisnya (Whibley *et al.*, 2019; Marta *et al.*, 2020).

Selain karena faktor luka pada bagian tubuh yang dipoerasi dan faktor habisnya pengaruh obat anastesi, ada beberapa faktor lain yang kemungkinan besar mempengaruhi intensitas skala nyeri “sedang” yang dirasakan oleh sebagian besar pasien *post-SC* dalam penelitian ini, yaitu: umur, tingkat pendidikan, depresi atau kecemasan dan riwayat melahirkan.

Pertama, umur kemungkinan besar berpengaruh pada skala nyeri sedang pada sebagian besar responden sebelum diberikan inhalasi aromaterapi Lavender, karena secara teoritis umur yang lebih tua biasanya terkait dengan tekanan psikologis dan lemahnya fungsi fisik (Mailawati *et al.*, 2020). Orang dewasa biasanya akan mengalami suatu perubahan neurofisiologis dan mungkin juga akan mengalami penurunan persepsi sensorik tentang stimulus serta mengalami peningkatan ambang nyeri (Sugathot and Nugrahaningtyas, 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setengah responden (45.2%) berumur dalam kategori 61-30 tahun (dewasa) sesuai dengan parameter Departemen Kesehatan (Depkes, 2009). Karena itu, wajar jika sebagian besar responden mengalami nyeri sedang. Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian Borges *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa umur berpengaruh signifikan terhadap tingkat nyeri pasien *post-SC* (*P-value* sebesar 0,040).

Kedua, tingkat pendidikan kemungkinan besar berpengaruh pada skala nyeri sebagian besar responden sebelum diberikan inhalasi aromaterapi Lavender, karena tingkat pendidikan yang lebih rendah akan lebih susah mengontrol rasa nyeri yang dirasakan. Demikian juga sebaliknya, pendidikan tinggi akan cenderung mudah mengontrol rasa sakit secara efektif (Lanitis *et al.*, 2020). Oleh karena itu, wajar apabila sebagian besar skala nyeri responden hanya berada pada kategori sedang. Karena sebagian besar dari mereka mencapai pendidikan pada level perguruan tinggi (D3/S1-S3), sehingga mereka cenderung bisa mengontrol skala nyeri yang dirasakan hanya pada level sedang saja. Hal

ini juga dibuktikan dengan penelitian Mailawati *et al.* (2020) yang menunjukkan temuan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat nyeri kronis pasca operasi bedah mayor ($P\text{-value} = 0,038$). Bahkan, penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pendidikan dinyatakan sebagai satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap tingkat nyeri pasien pasca-operasi bedah mayor.

Ketiga, depresi atau kecemasan kemungkinan besar berpengaruh pada skala nyeri sedang sebagian besar responden sebelum diberikan inhalasi aromaterapi lavender, karena secara teoritis tingkat depresi atau kecemasan ini akan menjadi refleksi diri pasien dalam mempersiapkan diri menghadapi situasi penderitaan seperti nyeri. Pasien dengan tingkat depresi dan kecemasan yang rendah merupakan predisposisi untuk mengatasi nyerinya (Borges *et al.*, 2019). Artinya, pasien dengan depresi atau kecemasan yang rendah lebih siap menghadapi nyeri pasca operasi. Kemungkinan besar, pasien *post-SC* pada penelitian memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang relatif rendah, sehingga skala nyeri mereka berada pada kategori sedang saja. Hanya saja, penelitian ini tidak melakukan identifikasi pada aspek kecemasan atau depresi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Borges *et al.* (2020) menunjukkan bahwa dalam analisis multivariat, kecemasan merupakan salah satu prediktor faktor resiko tingkat nyeri pasca operasi sesar ($P\text{-value} = 0,006$).

Keempat, riwayat melahirkan. Seorang ibu yang sebelumnya telah pernah mengalami proses melahirkan (multipara) biasanya lebih bisa mengendalikan nyeri. Selain itu, seorang ibu yang telah mengalami proses

kelahiran lebih dari satu kali akan memiliki persepsi dan toleransi yang lebih tinggi terhadap nyeri dibandingkan dengan ibu yang baru pertama kali melahirkan. Persepsi dan toleransi tersebut akan memotivasi pasien untuk berangsur menurunkan dan menghilangkan rasa nyeri (Rejeki, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas (83.9%) responden memiliki riwayat persalinan sesar. Artinya, mayoritas responden sudah pernah mengalami proses kelahiran. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa skala nyeri responden sebelum diberikan inhalasi Lavender hanya berada pada kategori sedang.

5.2.2 Skala Nyeri Pasien *Post SC* di RS Prima Husada Malang setelah Diberikan Inhalasi Aromaterapi Lavender

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden mengeluh nyeri *post-SC* “ringan” sebanyak 19 orang (61.3%) dengan rata-rata sebesar 3.4839 (ringan) setelah diberikan inhalasi aromaterapi Lavender. Hal itu berdasarkan pengukuran nyeri menggunakan lembar observasi NRS. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata skala nyeri *post-SC* sebelumnya, maka rata-rata skala nyeri tersebut telah mengalami penurunan (rata-rata skala nyeri *post-SC* sebelumnya sebesar 5.4839 atau kategori sedang). Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemberian inhalasi aromaterapi Lavender pada responden. Pemberian inhalasi aromaterapi pada umumnya, termasuk aromaterapi Lavender, biasanya dilakukan selama 2 hari dengan frekuensi 2 kali dalam sehari berdasarkan penelitian Kakuhe and Rambli (2019) dan Rohimah and Utami (2021).

Namun karena permintaan dari rumah sakit agar pasien tidak terganggu, maka akhirnya *treatment* tersebut pada penelitian ini dimodifikasi menjadi sekali sehari selama 3 hari dengan durasi tiap dilakukan *treatment* yaitu 30 menit dan dosis sebanyak 4-5 tetes minyak esensial Lavender yang dicampur dengan 10 cc air. Kemudian *teratment* tersebut dimulai 6 jam setelah diberikan terapi farmakologi (analgesik).

Terjadinya penurunan skala nyeri *post-SC* pada sebagian besar responden peneliian ini tentu karena pemberian inhalasi aromaterapi Lavender yang diberikan sebanyak 3 kali selama 3 hari telah bekerja dengan baik. Aromateapi Lavender bisa menurunkan nyeri *post-SC*, karena ketika minyak esensial tersebut dihirup memang berfungsi untuk meningkatkan gelombang-gelombang alfa yang ada di dalam otak dan gelombang-gelombang tersebut akan berfungsi untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi yang menghirupnya (Fiesta, 2019). Menurut Herlyssa *et al.* (2020), rasa nyeri *post-SC* tersebut akan berkurang karena molekul-molekul dari minyak esensial tersebut akan diterima oleh sejumlah sel reseptor yang ada di dalam lapisan hidung dan akan terjadi proses pengiriman sinyal-sinyal ke dalam otak yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem otak limbik yang ada di dalam otak. Alhasil, ketika terjadi demikian, maka akan berpengaruh pada suasana hati, emosi dan memori untuk menghasilkan neurohormon di dalam endorpin dan encephalin dimana dua hal itu berfungsi untuk menurunkan dan menghilangkan rasa nyeri. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian Anjelia (2021) yang menunjukkan bahwa minyak esensial oil lavender

telah berpengaruh secara signifikan terhadap nyeri *post-SC* ($P\text{-value} = 0,001$).

5.2.3 Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri Pasien *Post SC* di RS Prima Husada Malang

Hasil analisis uji *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan ada pengaruh signifikan pemberian inhalasi aromaterapi Lavender terhadap perubahan skala nyeri pasien *post SC* di RS Prima Husada Malang ($P\text{-value} = 0.000 < 0.005$). Pemberian inhalasi aromaterapi Lavender bisa berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan skala nyeri pasien *post-SC*, karena aromaterapi Lavender tersebut pada dasarnya dapat memberikan efek analgesik pada orang yang menghirupnya (Said *et al.*, 2022). Hal itu bisa dipahami, karena apabila dilihat dari kandungannya, aromaterapi ini mengandung komponen *linalol* dan *linalyl* asetat dimana efek keduanya adalah relaksasi yang bisa memberikan rasa nyaman, tenang dan rileks. Kandungan *linalool*-nya sebesar 51% dan *linalyl*-nya sebesar 35% dimana keduanya berguna sebagai media relaksasi, mengurangi nyeri dan stres (Potter and Perry, 2019). Karena itu, efek relaksasi yang dihasilkan dari inhalasi aromaterapi Lavender akan menjadikan pikiran pasien *post-SC* tenang dan nyaman (Shiddiqiyah and Utami, 2023).

Sementara apabila dilihat dari aromanya, aromaterapi Lavender mengandung aroma floral, manis dan tambahan aroma balsam (Sarwinanti and Istiqomah, 2019). Selain itu, minyak esensial Lavender

ini memiliki khasiat sebagai pereda nyeri dan hipotensif antipasmodik, sehingga rasa nyeri yang dirasakan penghirupnya bisa berkurang (Fiesta, 2019). Karena itu, wajar jika responden penelitian ini mengalami perubahan nyeri post-SC setelah menghirup aromaterapi Lavender tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Anwar *et al.* (2019) bahwa ketika minyak esensial lavender dihirup, maka akan meningkatkan gelombang-gelombang alfa yang terdapat di dalam otak. Ketika hal itu terjadi, maka akan menyebabkan seseorang merasakan ketenangan dan meredakan kecemasan atau stres yang dirasakannya karena efek relaksasi yang dihasilkannya. Efek relaksasi itu bisa muncul, karena ketika aroma terapi yang dihirup dengan komponen kimia utama (*linalool* dan *linalyl asetat*) akan menghasilkan bulbous olfactory terbuka, kemudian ke *system limbic* dan otak dimana *system limbic* sebagai pusat nyeri. Lobus limbik ini terdiri dari hipocampus dan amigdala yang akan mengaktifkan hipotalamus untuk mengeluarkan hormon dan neurotransmitter. Molekul minyak esensial akan menstimulasi lobus limbik dan hipotalamus melalui otak yang akan mengontrol kerja otot jantung, tekanan darah, nadi dan pernafasan serta keseimbangan hormonal, dimana unsur aromatik akan mempengaruhi status emosional, sehingga menimbulkan efek secara fisiologi dan psikologi (Shiddiqiyah and Utami, 2023). Karena itu, wajar jika skala nyeri responden penelitian mengalami perubahan (penurunan) setelah pemberian inhalasi aromaterapi Lavender tersebut.

Temuan penelitian ini bukanlah satu-satunya temuan penelitian yang menyatakan demikian. Sebelumnya, penelitian Anwar *et al.* (2019) juga menyatakan hal yang senada bahwa terdapat pengaruh signifikan aromaterapi lavender terhadap penurunan intensitas nyeri pasien paska operasi *sectio caesarea* ($P\text{-value} = 0.000$). Hal ini juga didukung oleh penelitian Haryanti and Patria (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan aromaterapi lavender terhadap nyeri pada ibu bersalin *post-SC* ($P\text{-value} = 0,000$).

5.3 Implikasi Keperawatan

Penelitian ini memiliki implikasi keperawatan, yaitu semestinya lembaga pelayanan kesehatan dan keperawatan tidak hanya berfokus pada terapi farmakologis untuk menurunkan nyeri pada pasien *post-SC*, tetapi juga mengombinasikannya dengan terapi non-farmakologis seperti aromaterapi Lavender. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa intervensi non-farmakologis tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan skala nyeri pada pasien *post-SC*.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Sebagian besar pasien post SC di RS Prima Husada Malang mengeluh nyeri “sedang” sebanyak 22 orang (71%) sebelum diberikan inhalasi aromaterapi Lavender;
2. Sebagian besar di RS Prima Husada Malang mengeluh nyeri “ringan” sebanyak 19 orang (61.3%) setelah diberikan inhalasi aromaterapi Lavender; dan
3. Ada pengaruh signifikan pemberian inhalasi aromaterapi lavender terhadap perubahan skala nyeri pasien *post SC* di RS Prima Husada Malang.

6.2 Saran

Penelitian ini menyarankan kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Pihak Rumah Sakit

Pihak rumah sakit yang menjadi lokasi penelitian ini hendaknya memberikan terapi non-farmakologis (inhalasi aromaterapi Lavender) sebagai terapi kombinasi atau tambahan atas terapi farmakologis (obat anti-nyeri) untuk menurunkan skala nyeri pada pasien *post-SC*. Hal itu karena temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aromaterapi Lavender berpengaruh terhadap tingkat nyeri pasien *post-SC*.

2. Institusi Pendidikan Keperawatan

Institusi pendidikan keperawatan hendaknya menjadikan temuan penelitian ini sebagai bahan kajian opsional atau tambahan untuk memperkaya khazanah keilmuan mahasiswa keperawatan berbasis pada penelitian lapangan yang sifatnya kuantitatif dengan pendekatan eksperimen.

3. Peneliti Lanjutan

Peneliti lanjutan hendaknya memperkaya variabel independen dengan mengangkat tema sejenis lainnya seperti pemberian kombinasi aromaterapi Lavender dengan terapi non-farmakologis lain (Aromaterapi Lemon atau minyak kayu putih) yang tampaknya jarang diteliti sebelumnya, sehingga penelitian pada tema tingkat nyeri *post-SC* ini menjadi semakin komprehensif.

4. Pasien atau Responden Penelitian

Pasien atau responden penelitian ini sebaiknya menjadikan inhalasi aromaterapi Lavender sebagai salah satu terapi tambahan, karena selain terapi tersebut secara signifikan berpengaruh pada penurunan skala nyeri *post-SC*, aromaterapi tersebut juga sangat mudah dilakukan secara mandiri di rumah dan tidak memiliki efek samping yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdraboo, R., Amasha, H., Ali, S., 2020. Effectiveness of Inhalation of Lavender Oil in Relieving Post-Caesarean Section Pain. *Malaysian J. Nurs.* 12, 113–122. <https://doi.org/https://ejournal.lucp.net/index.php/mjn/article/view/1118>
- ACOG, 2023. Caesarean Birth [WWW Document]. URL <https://www.acog.org/womens-health/faqs/cesarean-birth>
- Akmal, M., Indahaan, Z., Widhawati, Sari, S., 2021. *Ensiklopedi Kesehatan untuk Umum*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Anggraeni, N., Nikmah, N., Qomari, S., 2021. The Impact of Combination Theapy Utilizing Citrus Limon Aromatherapy and Mozart Classical Music Distraction Therapy to Reduce the Pain Intensity in Post Sectio Caesarean Mothers. *J. Ilm. Obs.* 13, 262. <https://doi.org/https://stikes-nhm.e-journal.id/JOB/article/view/1223>
- Anjelia, N., 2021. The Effect of Lavender Essential Oil on Post-Caesarean Section. *J. Matern. Child Heal. Sci.* 1.
- Anwar, M., Astuti, T., Bangsawan, M., 2019. Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Intensitas Neri Pasien Paska Operasi Sectio Caesarea. *J. Keperawatan* 14, 84.
- Bertone, A.C., Dekker, R.L., 2021. Aromatherapy in Obstetrics: A Critical Review of Literature. *Clin. Obstet. Gynecol.* 64, 572–588. <https://doi.org/10.1097/GRF.0000000000000622>
- Borges, N., Pereira, L., Moura, L., Silva, T., Pedroso, C., 2019. Predictors for Moderate to Severe Acute Postoperative Pain after Caesarean Section. *Pain Res Manag.*
- Borges, N.C., Deus, J.M. de, Guimareas, R.A., Conde, D.M., Bachion, M.M., 2020. The Insidence of Chronic Pain Following Cesarean Section and Associated Risk Factors: A Cohort of Women Followed Up for Three Months. *PLoS One*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238634>
- Dahlan, S., 2019. *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan*, Edisi 6. ed. Salemba Medika, Jakarta.
- Demelash, G., Berhe, Y., Gebregzi, A., Chekol, W., 2021. Prevalance and Factors Associated with Postoperative Pain After Caesarean Section at a Comprehensive Specialized Hospital in Norwest Ethiopia: Prospective Observational Study. *Dovepress Open Acces to Sci. Med. Res.* 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.2147/OAS.S347920>

- Doenges, M.E., 2020. Rencana Asuhan Keperawatan dan Pedoman untuk Perencanaan dan Pendokumentasian Perawatan Pasien. Penerbit EGC, Jakarta.
- Febriantri, N., Machmudah, 2021. Penurunan Nyeri Pasien Post Sectio Caesarea Menggunakan Terapi Teknik Relaksasi Benson. *J. Ners Muda* 2, 31. <https://doi.org/https://doi.org/10.26714/nm.v2i2.6239>
- Fiesta, O., 2019. Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Nyeri Persalinan Kala I di BPM Kota Palembang Tahun 2018. Skripsi Jur. Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang.
- Gedefaw, G., Demis, A., Waltengus, F., 2020. Prevalence, Indications, and Outcomes of Caesarean Section Deliveries in Ethiopia: A systematic Review and Meta-Analysis. *Patient Saf. Surgency* 14. <https://doi.org/10.1186/s13037-020-00236-8>
- Haryanti, R., Patria, A., 2019. Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender terhadap Nyeri pada Ibu Post Sectio Caesarea Hari Pertama di Ruang Bersalin Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. *e-Jurnal Malahayati* 1.
- Herawati, I., 2022. Efektivitas Kombinasi Pemberian Aromaterapi Lavender dan Distraksi Terapi Musik Klasik (Mozart) terhadap Penurunan Intensitas Skala Nyeri pada Ibu Post Sectio Caesarea. *J. Antara Kebidanan* 5, 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.33755/jkk.v9iSpecial%20Edition.544>
- Herawati, I., Sari, P., Ermanto, B., 2023. Effectiveness of Lavender Aromatherapy on Reducing Pain Intensity after 24 Hours Post Sectio Caesarea. *J. Keperawatan Komprehensif* 9, 120–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.33755/jkk.v9iSpecial%20Edition.544>
- Herlyssa, Jehanara, Dwi, E., 2020. Aromateapi Lavender Esensial Oil Berpengaruh Dominan terhadap Skala Nyeri 24 Jam Post Seksio Sesaria. *J. Poltekkes* 9.
- Juliani, W., Sanjaya, R., Veronica, S., Ifayanti, H., 2021. Pemberian Aromaterapi Lavender terhadap Pengurangan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif. *Wellness Heal. Mag.* 3, 155–160. <https://doi.org/https://www.wellness.journalpress.id/wellness/article/view/3222/pdf>
- Kakuhese, F., Rambli, C., 2019. Penebarapan Teknik Relaksasi Aromaterapi Lavender pada Klien dengan Nyeri Post-Sectio Caesare. *J. Ilm. Sederhana* 3, 52–58.
- Kasdu, D.A., 2020. Operasi Caesar: Masalah Ibu an Neonatal. Yaysan Bina Pustaka, Jakarta.
- Kemenkes, 2022. Manajemen Nyeri [WWW Document]. URL https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1052/manajemen-nyeri

- Kemenkes RI, 2018. Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. <https://doi.org/https://doi.org/1> Desember 2013.
- Kintu, A., Abdulla, S., Adeyemi, J., Olufolabi, 2019. Postoperative Pain after Cesarean Section: Assesment and Management in a Tertiary Hospital in Low-Income Country. *BMC Health Serv. Res.*
- Kristiani, D., Lathifah, L., 2019. Pengaruh Teknik Relaksasi Autogenik terhadap Skala Nyeri pada Ibu Post Operasi Sectio Caesarea (SC) di RSUD Banyumas. *Skripsi Universiats Soedirman*. <https://doi.org/https://sinelitabmas.unsoed.ac.id/google-doc/565285/pengaruh-teknik-relaksasi-autogenik-terhadap-skala-nyeri-pada-ibu-post-operasi-sectio-caesaria-sc-di-rsud-banyumas>
- Lanitis, S., Mimigianni, C., Raptis, D., Sourtse, G., Sgourakis, G., Karaliotas, C., 2020. The Impact of Educational Status on the Postoperative Perseption of Pain. *Korean J. Pain* 28, 265.
- Larsson, C., Djuvfelt, E., Lindam, A., Tunon, K., Nordin, P., 2021. Surgical Complications after Caesarean Section: A Population-Based Cohort Study. *PLoS One* 16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258222>
- Mailawati, T., Laksono, R., Fatoni, A., 2020. Hubungan Faktor Sosio-Demografi dengan Angka Kejadian Nyeri Kronik pada Pasien Pasca Operasi Bedah Mayor di Rumah Sakit Dr Saiful Anwar Malang. *J. Anesthesia Pain* 1, 1–6.
- Marta, O., Aini, N., Nurhaliza, S., Setyowati, L., Mashfufa, E., Ariani, T., 2020. Pain Experience After Caesarean Section: A Qualitative Study. *Knowledge*.
- Maryunani, A., 2020. *Manajemen Kebidanan Terlengkap*. Penerbit EGC, Jakarta.
- Muchtaridi, Moelyono, 2021. *Aromaterapi: Tinjauan Aspek Kimia dan Medisinal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ningtyas, W.R., Amanupunyo, N.A., Manueke, I., Ainurrahmah, Y., Pramesti, D., 2023. *Bunga Rampai Manajemen Nyeri*. PT. Media Pustaka Indo, Cilacap.
- Nurhasanah, 2022. Pengaruh Perbedaan Pemberian Aromaterapi Lavender dan Lemon terhadap Tingkat Nyeri pada Pasien Post Sectio Caesarea (SC) Hari ke 1-2 di RSIA Puri Malang. *Dukumen Cetak Univ. Muhammadiyah Malang*.
- Nursalam, 2019. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis, Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*. Salemba Medika, Jakarta.
- Pemkot Malang, 2023. Data Persalinan SC dan Normal Januari-Desember 2022 [WWW Document]. URL <https://katalog.data.go.id/dataset/data-persalinan->

sc-dan-normal-bulan-januari-2022

- Potter, P., Perry, A., 2019. *Fundamentals of Nursing* (9th ed). St. Louis, Missouri Mosby, Elsevier.
- Purwaningtyas, N., Masrurroh, 2020. Efektivitas Pemberian Terapi Musik Klasik terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Sectio Caesarea di Ruang Flamboyan 1 RSUD Salatiga. *J. Holist. Heal. Sci.* 2. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238634>
- Purwoto, A., Tribakti, I., Cahaya, M.R.F., 2023. *Manajemen Nyeri*. Global Ekskutif Teknologi, Bandung.
- Rahman, G.A., 2021. Pengaruh Aromaterapi Lavender Esensial Oil terhadap Nyeri Persalinan pada Primigravida Kala I di RSUD Koja Tahun 2021. *Publ. Ilm. Progr. Stud. Pendidik. Profesi Bidan Poltekkes Jakarta III*. <https://doi.org/10.24198/jf.v15i2.12907>
- Rahmayani, S., Machmudah, 2022. Penurunan Nyeri Post Sectio Caesarea Menggunakan Aromaterapi Levender di Rumah Sakit Permata Medika Ngaliyan Semarang. *Ners Muda* 3, 291–298. <https://doi.org/https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/nersmuda/article/view/8377/0>
- Raja, S., Carr, D., Cohen, M., Finnerup, N., Flor, H., Gibson, S., Keefe, F., Mogil, J., Ringkamp, M., Sluka, K., Song, X., Stevens, B., Sullivan, M., Tutelman, P., Ushida, T., Vader, T., 2021. The Revised IASP Definition of Pain: Concepts, Challenges and Compromises. *HHS Public Access* 161, 1976–1982. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939>
- Rejeki, S., 2021. *Buku Ajar Manajemen Nyeri dalam Proses Persalinan (Non-Farmaka)*. Unimus Press, Sumatera.
- Rini, S., Susanti, I.H., 2019. Penurunan Nyeri pada Ibu Post-Sectio Caesarea Intervensi Biologic Nurturing Baby Leed Feeding. *Medisains J. Ilm. Ilmu-Ilmu Kesehatan*. 16, 83.
- Roberia, N., 2019. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penyembuhan Luka Post Sectio-Caesarea di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. *Publ. Ilm. Politek. Kesehatan Medan* 19–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258222>
- Rohimah, S., Utami, I.T., 2021. Pemberian Aromaterapi Labender terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif pada Ibu Bersalin Primipara. *J. Hum. Care* 6, 416. <https://doi.org/https://ojs.fdk.ac.id/index.php/humancare/article/download/1244/pdf>

- Roofthoof, E., Joshi, G., Rawal, N., Velde, M., 2020. Prospect Guidline for Elective Caesarean Section: Updat Systematic Review and Procedure-Specific Postoperative Pain Management Recommendationa. *Anaesthesia* 76, 665–680. <https://doi.org/10.1111/anae.15339>
- Rubianti, E., Wijayanti, K., Rohmayanti, 2022. The Effectiveness of lavender Aromatherapy Against Pain in Post Sectional Caesarean Patients: Lliterature Review. 16th Univ. Res. Colloquium 2022. <https://doi.org/https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2472>
- Said, F.F.I., Oktavia, E., Astuti, D., 2022. Pemberian Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Nyeri Pada Ibu Pasca Sectio Caesarea: Literatur Review. *J. Kesehat. Panrita Husada* 7.
- Sanjaya, R., Fara, Y., Ifayati, H., Sari, G., 2023. Effectiveness of Lavender Aromatherapy on Caesarean Postoperaive Pain. *Int. J. Matern. Midwifery Sci.* 1, 1–4. <https://doi.org/https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/IJMMS/article/view/riona>
- Santriwati, 2019. Pengaruh Pemberian Inhalasi Aromaterapi terhadap Kejadian Mual dan Muntah pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Skripsi Progr. Stud. S1 Keperawatan Stikes Panakkukang Makassar. <https://doi.org/https://stikespanakkukang.ac.id/assets/uploads/alumni/e657d0e12377241a85d7d22901d186d1.pdf>
- Sarwinanti, Istiqomah, N., 2019. Perbedaan Aromaterapi Lavender dan Lemon untuk Menurunkan Mual Muntah Ibu Hamil. *J. Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah* 15, 185.
- Setiadi, 2019. Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Shiddiqiyah, N., Utami, T., 2023. Penerapan Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Post Sectio Caesarea Di RSUD Kardinah Tegal. *Detect. J. Inov. Ris. Ilmu Kesehat.* 1.
- Sofiani, V., Pratiwi, R., 2021. Review Artikel: Pemanfaatan Minyak Astiri pada Tanaman sebagai Aromaterapi dalam Sediaan Farmasi. *Farmaka* 15, 119–131. <https://doi.org/10.24198/jf.v15i2.12907>
- Solehati, T., Kosasih, C.E., Jayanti, T.N., Ardiyanti, A., Sari, R.I., 2020. Terapi Non-farmakologi Nyeri pada Persalinan. Penerbit EGC, Jakarta.
- Suastini, Pawestri, 2021. Penurunan Intensitas Nyeri Luka Post-Sectio caesarea Menggunakan Mobilisasi Dini. *Ners Muda* 2, 91–99.

<https://doi.org/https://doi.org/10.26714/nm.v2i3.8247>

- Sugathot, A., Nugrahaningtyas, W., 2019. Hubungan Umur dengan Tingkat Nyeri Pasca Peralinan setelah Melakukan Teknik Relaksasi Napas Dalam. *J. Med. Respati* 13.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sumarni, R., Astuti, I., Karmilah, N., 2019. The Relations of Aromatherapy with the Intensity of Pain on Labor Women Stage I Active Phase in PMB Cimahi City. *Third International Semin. Glob. Heal. Technol. Transform. Healthc. Better Life* 3, 21. <https://doi.org/https://repository2.stikesayani.ac.id/index.php/isgh3>
- Sung, S., Mahdy, H., 2022. Caesarean Section [WWW Document]. URL <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546707/>
- Tabatabaeichehr, M., Mortazavi, H., 2020. The Effectiveness of Aromatherapy in the Management of Labor Pain and Anxiety: A Systematic Review. *Ethiop. J. Health Sci.* <https://doi.org/10.4314/ejhs.v30i3.16>
- Tirtawati, G.A., Purwandari, A., Yusuf, N.H., 2020. Efektifitas Pemberian Aroma Terapi Lavender terhadap Intensitas NYeri Post-Setio Caesaea. *Jidan J. Ilm. Bidan* 7, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.47718/jib.v7i2.1135>
- University of Florida Health, 2019. Pain Assesment Scales/Tools [WWW Document]. URL <https://pami.emergency.med.jax.ufl.edu/resources/provider-resources/pain-assessment-scales/>
- Wahyu, H., Lina, L., 2019. Terapi Kompres Hangat dengan Aroma Jasmine Esential Oil terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Sectio Caesarea. *J. Telenursing* 1, 406–415.
- Wathina, Z., Fajrin, S.L., Quratuaini, D.S., Alif, A.D.H., 2023. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pesalinaan Sectio Caesarea. *Pros. Semin. H-Tech* 2. <https://doi.org/https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech>
- Whibley, D., Alkandari, N., Kristensen, 2019. Sleep and Pain: A Systematic Review of Studies of Medication. *Clin. J. Pain* 35, 544–558.
- WHO, 2021. Caesarean Section Rates Continue to Rise Amid Growing Inequalities in Access [WWW Document]. URL <https://pssjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13037-020-00236-8>
- Wijayanti, I., Handayani, S., Subarto, C., Aryani, F., 2022. The Effectiveness of Lavender and Jasmine Aroma Therapy Towards Pain Level. *J. Ners dan*

Kebidanan Indones. 10, 240–250.
<https://doi.org/https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JNKI/article/view/2447>.

Lampiran 1. Surat Permohonan Menjadi Responden Penelitian**SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN**

Kepada Yth.
Calon Responden
di tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lita Oktavian

NIM : 2022035122

Program Studi : S1 Keperawatan STIKES Husada Jombang

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul “Perbedaan Pengaruh Terapi Musik Klasik Mozart dan Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang”. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden. Semua informasi dari hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jika Saudari bersedia, maka saya mohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan yang saya lampirkan. Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden, saya ucapkan terimakasih.

Jombang, 7 Maret 2024

Hormat saya,

Lita Oktavian

Lampiran 2. Lembar Penjelasan kepada Responden Penelitian

LEMBAR PENJELASAN KEPADA RESPONDEN

Saya Lita Oktavian (NIM. 2022035122) adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Husada Jombang yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Pengaruh Terapi Musik Klasik Mozart dan Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana keperawatan (S.Kep).

Selanjutnya, lembar observasi yang akan diberikan kepada Saudari ini merupakan instrumen dalam penelitian ini dimana dimaksudkan untuk mengetahui tingkat nyeri Saudari setelah melakukan proses operasi SC di RS Prima Husada Malang.

Adapun manfaat penelitian ini secara umum, diharapkan hasilnya dapat menambah ilmu tentang topik di atas. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan wadah untuk memperkaya pengetahuan peneliti dan untuk mengimplementasikan keilmuan peneliti yang telah didapatkan di bangku kuliah. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan kajian untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut mengenai topik di atas.

Jika Saudari menyetujui, selanjutnya saya akan memberikan *informed consent* (lembar persetujuan menjadi responden) untuk ditandatangani. Saya mengharapkan kesediaan Saudari untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Partisipasi Saudari bersifat sukarela dan Saudari berhak untuk menolak menjadi responden tanpa sanksi apapun. Demikian lembar penjelasan ini saya buat, atas partisipasinya saya ucapkan terimakasih

Lampiran 3. *Informed Consent****INFORMED CONSENT***

Saya yang bertandatangan di bawah ini, bersedia menjadi responden penelitian setelah diberikan penjelasan oleh peneliti, yaitu:

Nama : Lita Oktavian

NIM : 2022035122

Judul : Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak merugikan saya sebagai responden. Oleh sebab itu, saya bersedia menjadi responden dari penelitian ini.

Jombang, 7 Maret 2024

Peneliti

Responden

Lita Oktavian

Lampiran 4. Lembar Observasi

LEMBAR OBSERVASI

DATA DEMOGRAFI

Hari, tanggal, dan Jam :

No Responden :

Umur : ☐ ≤ 20 tahun
☐ 21-25 tahun
☐ 26 – 30 tahun
☐ ≥ 30 tahun

Pendidikan : ☐ SD/ sederajat
☐ SMP/ sederajat
☐ SMA/ sederajat
☐ Perguruan tinggi (D3/S1-S3)

Pekerjaan : ☐ Karyawan swasta
☐ PNS/TNI/Polri
☐ Petani
☐ Pedagang
☐ Lain-lain.....

Riwayat Bersalin : ☐ Sesar
☐ Normal

Riwayat Kehamilan : ☐ Kehamilan ke-1
☐ Kehamilan ke-2
☐ Dst.....

TINGKAT NYERI *POST SC*

Petunjuk Pengisian:

Tandai (dengan cara melingkari) skala nyeri berikut ini dengan tanda lingkaran pada angka yang menurut pasien dapat mewakili tingkat nyeri *post-sectio caesarea* yang dirasakan saat ini.

Keterangan:

1. Skala 0 : Tidak ada rasa nyeri yang dialami;

2. Skala 1-3 : nyeri ringan;
3. Skala 4-6: nyeri sedang;
4. Skala 7-9 : nyeri berat; dan
5. Skala 10 : nyeri sangat hebat.



Lampiran 5. SOP Pemberian Aromaterapi Lavender

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN AROMATERAPI (LAVENDER)

Pengertian	Aromaterapi lavender adalah penggunaan minyak esensial yang berasal dari tumbuhan (bunga lavender) dengan cara inhalasi (hirupan hidung).
Tujuan	Menurunkan tingkat nyeri
Sasaran	Pasien <i>post SC</i>
Tahap Kerja	1. Persiapan bahan a. Minyak esensial lavender dan minyak esensial lemon b. Air 2. Persiapan alat a. Diffuser 3. Pelaksanaan a. Lakukan pengukuran tingkat nyeri <i>post SC</i> responden sebelum dilakukan intervensi dengan aromaterapi lavender. b. Masukkan air sebanyak 10 cc ke dalam diffuser; c. Teteskan 4-5 tetes minyak esensial. d. Letakkan diffuser dalam ruangan tempat responden <i>post-sectio caesarea</i> dirawat. e. Nyalakan diffuser setelah 6 jam responden diberikan terapi analgesik. f. Durasi pemberian aromaterapi lavender selama 30 menit dan diulang setiap hari sampai hari ke-3. g. Setelah 3 kali intervensi (selama 3 hari) dilakukan, segera lakukan pengukuran tingkat nyeri <i>post SC</i> responden kembali. h. Dokumetasikan.
Terminasi	1. Alat-alat dibereskan, diffuser dimatikan setelah intervensi selesai dilakukan. 2. Observasi tingkat nyeri responden dengan lembar observasi NRS. 3. Dokumentasikan pada lembar observasi yang telah disediakan. 4. Berikan dukungan kepada pasien. 5. Dokumentasikan jawaban responden.

Lampiran 6. Lembar Konsultasi

LEMBAR KONSULTASI

NAMA : Lita Okatavian
 NIM : 2022035122
 JUDUL SKRIPSI : “Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap
 Perubahan Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS
 Prima Husada Malang”
 PEMBIMBING 1 : Kusuma Wijaya Ridi .S.Kep., Ns., MNS

NO	TANGGAL	HASIL KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIM- BING
1.	29 September 2023	Konsul Judul	
2.	02 Oktober 2023	Revisi Judul – ACC	
3.	19 Oktober 2023	Konsul BAB 1, BAB II, BAB III, BAB IV	
4.	16 November 2023	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	
5.	01 Desember 2023	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	
6.	19 Februari 2024	Revisi BAB IV	
7.			

LEMBAR KONSULTASI

NAMA : Lita Oktavian
NIM : 2022035122
JUDUL SKRIPSI : “Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Nyeri Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) di RS Prima Husada Malang”.
PEMBIMBING 2 : Gevi Mellya Sari, S.Kep., NS., M.Kep.,

NO	TANGGAL	HASIL KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	29 September 2023	Konsul Judul	
2.	01 Oktober 2023	Revisi Judul - ACC Judul	
3.	17 November 2023	Konsul BAB 1, BAB II, BAB III, BAB IV	
4.	28 November 2023	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	
5.	03 Desember 2023	ACC Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	
6.			
7.			

Lampiran 7. Tabulasi Data

Resp	Data Demografi											
	Umur	Kode	Alamat	Kode	Pedidikan	Kode	Pekerjaan	Kode	Riwayat Bersalin	Kode	Riwayat Kehamilan	Kode
R.1	29 tahun	3	Singosari	2	S1	4	Karyawan Swasta	1	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.2	24 tahun	2	Singosari	2	SMA	3	IRT	5	Tidak ada	3	Kehamilan ke-1	1
R.3	29 tahun	3	Lawang	3	S1	4	IRT	5	Normal	1	Kehamilan ke-2	2
R.4	35 tahun	4	Lawang	3	S1	4	Karyawan Swasta	1	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.5	36 tahun	4	Singosari	2	S1	4	Karyawan Swasta	1	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.6	24 tahun	2	Singosari	2	SMA	3	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.7	29 tahun	3	Singosari	2	D3	4	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.8	31 tahun	4	Singosari	2	S1	4	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.9	29 tahun	3	Karangploso	4	SMA	3	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.10	38 tahun	4	Lawang	3	SMP	2	Pedagang	4	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.11	24 tahun	2	Singosari	2	S1	4	IRT	5	Tidak ada	3	Kehamilan ke-1	1
R.12	26 tahun	3	Blimbing	1	SMP	2	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.13	27 tahun	3	Blimbing	1	S1	4	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.14	32 tahun	4	Lawang	3	D3	4	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.15	34 tahun	4	Lawang	3	D3	4	Karyawan Swasta	1	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.16	25 tahun	2	Blimbing	1	SMA	3	Karyawan Swasta	1	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.17	23 tahun	2	Lawang	3	D3	4	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.18	32 tahun	4	Singosari	2	S1	4	Perawat	6	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.19	25 tahun	2	Karangploso	4	S1	4	Karyawan Swasta	1	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.20	29 tahun	3	Singosari	2	D3	4	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.21	23 tahun	2	Blimbing	1	SMA	3	IRT	5	Tidak ada	3	Kehamilan ke-1	1
R.22	28 tahun	3	Blimbing	1	SMA	3	Pedagang	4	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2

R.23	28 tahun	3	Blimbing	1	SMA	3	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.24	26 tahun	3	Blimbing	1	S1	4	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.25	31 tahun	4	Lawang	3	S2	4	Guru	7	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.26	34 tahun	4	Blimbing	1	S1	4	IRT	5	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.27	28 tahun	3	Singosari	2	SMA	3	Pedagang	4	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.28	28 tahun	3	Blimbing	1	D3	4	Karyawan Swasta	1	Normal	2	Kehamilan ke-2	2
R.29	41 tahun	4	Lawang	3	S1	4	Perawat	6	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.30	27 tahun	3	Blimbing	1	D3	4	PNS/TNI/Polri	2	Sesar	1	Kehamilan ke-2	2
R.31	27 tahun	3	Blimbing	1	SMA	3	Karyawan Swasta	1	Normal	2	Kehamilan ke-2	2

Skala Nyeri Pasien Post-SC				
Resp	Sebelum Diberikan Inhalasi Aromaterapi Lavender	Kode	Setelah diberikan Inhalasi Aromaterapi Lavender	Kode
R.1	5	3	2	2
R.2	4	3	2	2
R.3	5	3	4	3
R.4	5	3	4	3
R.5	4	3	3	2
R.6	6	3	3	2
R.7	6	3	5	3
R.8	7	4	6	3
R.9	7	4	6	3
R.10	5	3	5	3
R.11	4	3	3	2
R.12	6	3	5	3
R.13	4	3	3	2

R.14	3	2	3	2
R.15	4	3	3	2
R.16	5	3	3	2
R.17	4	3	2	2
R.18	5	3	4	3
R.19	7	4	3	2
R.20	6	3	3	2
R.21	5	3	3	2
R.22	7	4	3	2
R.23	8	4	4	3
R.24	7	4	3	2
R.25	6	3	1	2
R.26	6	3	3	2
R.27	5	3	4	3
R.28	7	4	6	3
R.29	6	3	4	3
R.30	7	4	2	2
R.31	4	3	3	2

Lampiran 8. Hasil Analisis SPSS

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-25 tahun	7	22.6	22.6	22.6
	26-30 tahun	14	45.2	45.2	67.7
	> 30 tahun	10	32.3	32.3	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Alamat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Blimbing	11	35.5	35.5	35.5
	Singosari	10	32.3	32.3	67.7
	Lawang	8	25.8	25.8	93.5
	Karangploso	2	6.5	6.5	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP/Sederajat	2	6.5	6.5	6.5
	SMA/Sederajat	9	29.0	29.0	35.5
	Perguruan Tinggi (D3/S1-S3)	20	64.5	64.5	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Karyawan Swasta	8	25.8	25.8	25.8
	PNS/TNI/Polri	1	3.2	3.2	29.0
	Pedagang	3	9.7	9.7	38.7
	IRT	16	51.6	51.6	90.3
	Perawat	2	6.5	6.5	96.8
	Guru	1	3.2	3.2	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Riwayat_Persalinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesar	26	83.9	83.9	83.9
	Normal	2	6.5	6.5	90.3

	Tidak ada	3	9.7	9.7	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Riwayat_Kehamilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kehamilan ke-1	3	9.7	9.7	9.7
	Kehamilan ke-2	28	90.3	90.3	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Kode_Pretest

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Nyeri ringan (1-3)	1	3.2	3.2	3.2
	Nyeri sedang (4-6)	22	71.0	71.0	74.2
	Nyeri berat (7-9)	8	25.8	25.8	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Kode_Posttest

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Nyeri ringan (1-3)	19	61.3	61.3	61.3
	Nyeri sedang (4-6)	12	38.7	38.7	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pretest_Nyeri_Post_SC	31	3.00	8.00	5.4839	1.26151
Posttest_Nyeri_Post_SC	31	1.00	6.00	3.4839	1.23480
Valid N (listwise)	31				

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Posttest_Nyeri_Post_SC -	Negative Ranks	29 ^a	15.00	435.00
Pretest_Nyeri_Post_SC	Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
	Ties	2 ^c		
	Total	31		

a. Posttest_Nyeri_Post_SC < Pretest_Nyeri_Post_SC

b. Posttest_Nyeri_Post_SC > Pretest_Nyeri_Post_SC

c. Posttest_Nyeri_Post_SC = Pretest_Nyeri_Post_SC

Test Statistics^a

	Posttest_Nyeri_Post_SC - Pretest_Nyeri_Post_SC
Z	-4.773 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.